

INSTITUTO VIRTUDES

Formação em Virtologia

Virtologia Clínica

Apostila do Aluno

O aparelho psíquico · a consciência · o sofrimento · o manejo clínico

Módulos desta apostila

- 1 · O Inconsciente Operacional — como o aparelho psíquico calcula percepção e reação
- 2 · A Consciência — o estado de consciência (cérebro) e a Consciência (a alma)
- 3 · Dor, Sofrimento, Angústia e Sintoma — os quatro estados, pela Lei do Fluxo
- 4 · Manejos e Técnicas — a clínica no consultório e a Pirâmide das Virtudes como estratégia

Dr. Eduardo Casarotto

Criador da Virtologia · Instituto Virtudes · Instituto Humanar

2026

Ficha técnica

Título — Virtologia Clínica: Apostila do Aluno.

Autor — Dr. Eduardo Casarotto, criador da Virtologia, fundador do Instituto Virtudes e do Instituto Humanar. ORCID 0009-0001-8274-1405.

Finalidade — material didático de uso interno da Formação em Virtologia e dos programas de pós-graduação. Reprodução e distribuição restritas aos fins do curso.

Base editorial — os quatro módulos derivam, com adaptação didática, de Fundamentos da Virtologia, 3ª edição (2026), preservando o texto canônico da obra.

Constantes canônicas — todo o material observa as invariantes da Virtologia: as 33 virtudes da Pirâmide, a Lei do Fluxo ($PRF = E \times I \times PS \times FA \times PO \times LV$), as Faixas de Evolução e os sistemas neurofuncionais do Orgulho (SNO) e do Egoísmo (SNE).

© 2026 Instituto Virtudes. Todos os direitos reservados.

Sumário

Apresentação	4
Módulo 1 — O Inconsciente Operacional	6
Parte I — Por que falamos em “cálculo”	8
Parte II — Os dois níveis da matemática do inconsciente	8
Parte III — As operações primárias	9
Parte IV — A gramática dos símbolos: como ler as fórmulas	10
Parte V — Os vinte e um cálculos compostos	12
Parte VI — A hierarquia em camadas: cálculos sobre cálculos	16
Parte VII — As três grandes redes como cálculo	17
Parte VIII — Os mecanismos de defesa como cálculos	19
Parte IX — Os transtornos como cálculos do inconsciente operacional	21
Parte X — Orgulho e egoísmo, em síntese	23
Parte XI — A leitura clínica em camadas	23
Parte XII — Fronteira epistêmica	24
Módulo 2 — A Consciência	26
Parte I — O problema: duas palavras numa só	28
Parte II — O estado de consciência (Território da Neurociência)	29
Parte III — Os três estados do ego: os tipos de consciência	32
Parte IV — A Consciência (Território da Virtologia): a alma	36
Parte V — A única ponte: estruturar o ego, subir de faixas, tocar a Consciência	38
Parte VI — As faixas da Consciência: um continuum de acesso	38
Parte VII — As duas, lado a lado	40
Parte VIII — Método e fronteira epistêmica	40
Módulo 3 — Dor, Sofrimento, Angústia e Sintoma	43
Parte I — Dor: o impacto do real no cérebro	45
Parte II — Sofrimento: quando a dor não encontra Aceitação	47
Parte III — Aflição e Angústia: o medo do real e o medo do não-real	47
Parte IV — Sintoma: a solução que o cérebro inventa	49
Parte V — Os quatro estados lidos pela Lei do Fluxo	49
Parte VI — Orgulho e Egoísmo: por que amplificam cada estado	51
Parte VII — A direção da cura: da faixa primitiva ao Sentir	51
Parte VIII — Três quadros clínicos: luto, fibromialgia e pânico	53
Módulo 4 — Manejos e Técnicas	57
Parte I — O virtólogo: professor, treinador de vias neurais e analista	59
Parte II — Os três mapas do terapeuta	59
Parte III — O que é manejo, e por que ele é o centro prático	62
Parte IV — O Tripé Terapêutico: a estrutura de toda sessão	62
Parte V — Rapport, Conexão e Permissão: a progressão que abre a sessão	63
Parte VI — A Técnica da Permissão, em detalhe	65
Parte VII — O catálogo das técnicas: cada carta e o fator que ela move	67
Parte VIII — O tempo de sessão e o ritmo do insight	67
Parte IX — Técnicas de investigação estruturada	68
Parte X — Transferência, contratransferência e o cuidado do terapeuta	68
Parte XI — Manejo por faixa, por couraça e por discurso	70
Parte XII — A Pirâmide das Virtudes: o mapa estratégico de todo o manejo	72
Parte XIII — A grande regra diagnóstica e a ordem do trabalho	76
Parte XIV — Por que a técnica é inseparável da teoria	78

Apresentação

Esta apostila reúne quatro módulos que percorrem, em sequência, o núcleo clínico da Virtologia: primeiro **o aparelho psíquico em ação** — como o cérebro calcula percepção e reação (o Inconsciente Operacional); depois **a consciência**, separando com rigor o estado de consciência cerebral da Consciência como alma; em seguida **os quatro estados do sofrimento** — dor, sofrimento, angústia e sintoma, lidos pela Lei do Fluxo; e, por fim, **o manejo clínico**, o trabalho no consultório, coroado pela Pirâmide das Virtudes como estratégia de tratamento. É um caminho que vai do funcionamento da mente à prática da cura.

Os módulos não são independentes: cada um pressupõe o anterior. O Inconsciente Operacional dá a mecânica; a Consciência dá o horizonte; Dor, Sofrimento, Angústia e Sintoma dão o quadro clínico; e Manejos e Técnicas dão o método — e mostram, na Pirâmide, em que ordem inscrever cada virtude. Recomenda-se estudá-los na sequência apresentada.

Como usar esta apostila

Cada módulo segue a mesma arquitetura pedagógica, para que o estudo seja previsível e ativo:

- **Enquadramento e objetivos de aprendizagem** — o que o módulo entrega e o que você deverá dominar ao final;
- **Partes numeradas** — o desenvolvimento conceitual, com caixas de destaque, fórmulas e tabelas;
- **Síntese** — as proposições centrais reunidas para revisão rápida;
- **Questões para discussão e vinheta clínica** — o material de aplicação, para seminário e para a prática;
- **Referências** — as fontes para aprofundamento, a consolidar no padrão ABNT.

Sugestão de método, coerente com a própria Virtologia: ao abrir cada módulo, reconstrua de memória o módulo anterior antes de seguir (o efeito do teste consolida mais do que reler). Se o esforço de recuperação incomoda, é sinal de que a via está sendo aberta — se está fácil, provavelmente não está funcionando.

Uma nota de escopo e segurança, válida para toda a apostila. A clínica virtológica trabalha a parcela neurótica — os padrões de percepção e reação reestruturáveis por neuroplasticidade. Quadros com risco ou base orgânica e estrutural (transtorno bipolar, psicoses, depressão grave, dependência química, transtornos do neurodesenvolvimento, ideação suicida, risco a terceiros) exigem co-manejo com médico e psiquiatra, e às vezes estão fora do escopo de trabalho isolado do virtólogo. Reconhecer o limite e encaminhar é parte da competência clínica. Toda comunicação de risco segue protocolo próprio.

O Inconsciente Operacional

As operações primárias, os cálculos compostos e a arquitetura em camadas do funcionamento automático do cérebro

Dr. Eduardo Casarotto · Instituto Virtudes

“Todo inconsciente é operacional. Não existe nada perdido, solto, simbólico no sentido mágico do termo: tudo é cálculo. $1 + 2$ é sempre 3 — inclusive dentro da sua dor.”

Princípio fundamental da Virtologia

Enquadramento da aula

Esta aula apresenta o **Inconsciente Operacional** — o sistema pelo qual o cérebro, fora da decisão consciente do lobo frontal, processa a experiência afetiva. A tese que a sustenta é radical na sua simplicidade: o inconsciente não guarda símbolos num porão obscuro; ele *opera*. Aplica operações sobre valores de prazer e desprazer, e dessas operações resultam o sintoma, a defesa, a transferência, a culpa, a escolha amorosa, a posição na família, a relação com o dinheiro e a própria qualidade do fluxo da vida.

A consequência clínica é o fio condutor de tudo o que se segue: **não se interpreta a dor — lê-se a conta e recalcula-se a estrutura**. Onde a tradição hermenêutica pergunta “o que isto significa?”, a Virtologia pergunta “que operação está rodando, sobre que conteúdo, em que camada?”. É esse deslocamento — do sentido para a operação — que torna a clínica reproduzível e ensinável.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, o pós-graduando deverá ser capaz de:

- distinguir os **dois níveis** da matemática do inconsciente — as operações primárias e os cálculos compostos — e explicar por que a segunda deriva da primeira;
- identificar as **operações primárias** (soma de similaridades e as portas lógicas) e o substrato neural associado a cada uma;
- ler corretamente a **notação** dos cálculos — como frase clínica, não como aritmética — e reconhecer as três classes de símbolos e a marca de inferência indireta (†);
- reconhecer e aplicar os **vinte e um cálculos compostos**, das raízes do orgulho e da culpa aos cálculos do gatilho, do valor, da predição e do corpo;
- situar cada cálculo na **hierarquia em seis camadas** (do estado corporal à Lei do Fluxo) e ler as três grandes redes cerebrais como cálculos de arbitragem;

- traduzir os **mecanismos de defesa e os principais transtornos** em suas assinaturas calculatórias; e conduzir a leitura clínica camada a camada, respeitando a fronteira epistêmica do modelo.

Roteiro

Parte I — Por que “cálculo”. Parte II — Os dois níveis. Parte III — As operações primárias. Parte IV — A gramática dos símbolos. Parte V — Os vinte e um cálculos compostos. Parte VI — A hierarquia em camadas. Parte VII — As três grandes redes. Parte VIII — As defesas como cálculos. Parte IX — O corpo e a decisão. Parte X — Os transtornos como cálculos. Parte XI — Orgulho e egoísmo em síntese. Parte XII — A leitura clínica em camadas. Parte XIII — Fronteira epistêmica. Síntese, discussão e referências.

Parte I — Por que falamos em “cálculo”

O ponto de partida é uma afirmação sobre a natureza do automático. Tudo aquilo que o cérebro faz sem passar pela deliberação consciente opera sobre uma classificação binária elementar: prazer e desprazer. Essa é a herança que a Virtologia recolhe e radicaliza. Se o inconsciente *classifica* experiências em positivas e negativas, o passo seguinte é inevitável: ele *calcula* — e calcular é aplicar operações sobre valores.

É preciso um cuidado de método, para não “enterrar o triângulo no quadrado”. Quem chega da matemática reconhecerá os nomes das portas lógicas — E, OU, NÃO, XOR, implicação — usados com fidelidade à álgebra de Boole, mas aplicados a um material que Boole não tratou: a memória afetiva. Não é metáfora frouxa; é a afirmação de que o cérebro, ao associar memórias de prazer e desprazer, executa exatamente o tipo de operação que esses nomes designam. Quem chega da psicanálise reencontrará velhos conhecidos — recalque, projeção, transferência — relidos não como conteúdos de um porão simbólico, mas como *contas*. Mantém-se o fenômeno; muda-se a leitura.

Uma nota sobre o nome: de “booleano” a “operacional”

Em formulações anteriores, este sistema foi chamado de *inconsciente booleano*. Adota-se agora, em definitivo, **inconsciente operacional** — pela mesma razão que levou a antiga Lei de Casarotto a se tornar Lei do Fluxo: nomear a coisa pelo que ela faz, não por um caso particular do que ela faz. “Booleano” descrevia bem a operação fundante — a classificação binária e as portas lógicas que dela derivam. Mas o cérebro não para aí: sobre a base binária ele constrói cálculos de magnitude — acúmulo (Σ), limiar (θ), ponderação ($\gg$), ganho que oscila — que nenhuma álgebra estritamente binária comportaria. A lógica binária permanece como raiz; os pesos contínuos são o que se ergue sobre ela. O nome diz o que o sistema faz: opera.

Parte II — Os dois níveis da matemática do inconsciente

Existem dois níveis, e confundi-los é a origem de boa parte das dúvidas.

Nível 1 — As operações primárias. As portas lógicas do cérebro: a tabela-verdade do afeto. NÃO, E, OU, XOR, implicação e a soma de similaridades. São os operadores — os tijolos elementares.

Nível 2 — Os cálculos compostos. As contas montadas com esses operadores. Cada cálculo composto é uma combinação de operações primárias rodando sobre um conteúdo específico. É o que o clínico ouve no divã.

A tese do capítulo, em uma frase: **todo cálculo composto é uma composição de operações primárias**. E os grandes sistemas que a Virtologia já descreveu — o orgulho (SNO), o egoísmo (SNE), o cálculo familiar, a relação com o dinheiro e a própria Lei do Fluxo — são, todos, cálculos compostos de larga escala. Demonstrar isso é o que torna a clínica reproduzível.

Uma convenção de notação, herdada da 2ª edição: escrevemos $Operação(x) = Componente(x) + Componente(y)$. O sinal + **não** é adição aritmética: é o operador de soma de similaridades — “tudo que é igual se soma”. Cada cálculo composto traz uma ficha de quatro campos — operação, sítio dominante, sistema/eixo e polaridade clínica.

Parte III — As operações primárias

Apresentamos primeiro a soma de similaridades, porque é a operação que sustenta as demais.

1. Soma de similaridades — “tudo que é igual se soma”

$$A = B + C$$

Quando o inconsciente identifica que duas situações compartilham um traço, ele as *soma*: a carga afetiva da segunda se acrescenta à da primeira. É por isso que o trauma não “fica no passado” — cada repetição o reabastece. **Substrato**: é a tradução psíquica da plasticidade hebbiana — neurônios que disparam juntos fortalecem a conexão; o hipocampo generaliza padrões, a amígdala marca a saliência afetiva. A soma não é escolha, é potenciação — e é a razão pela qual tratar apenas “o fim da cadeia” não resolve.

2. Negação (NÃO) — a evitação

$$\neg x \rightarrow \text{evitar}(x)$$

A operação mais primitiva de defesa. Diante de uma memória de desprazer, o cérebro produz um *não*: bloqueia, evita, não vai. No limite, o NÃO recai sobre a própria percepção — a negação como recusa de reconhecer a realidade. **Substrato**: o córtex pré-frontal medial regula a resposta da amígdala, “desligando” estímulos que gerariam angústia (Ochsner & Gross, 2005).

3. Conjunção (E) — a coexistência

$$x \wedge y \rightarrow x \text{ e } y \text{ simultâneos}$$

O inconsciente faz coexistir dois estados que a consciência julgaria incompatíveis: amor e ódio pela mesma figura. Aqui está a propriedade decisiva — o inconsciente não entra em contradição lógica. **Substrato**: circuitos límbicos paralelos mantêm ativações de valência oposta sem que uma anule a outra; a integração, quando há, é tarefa do vmPFC.

4. Disjunção (OU) — o dilema

$$x \vee y \rightarrow \text{dilema}(x, y)$$

Duas saídas se apresentam e o cérebro as trata como abertas. O OU saudável mantém os dois ramos vivos — é a base da deliberação. A clínica frequentemente *reabre* um OU onde o orgulho havia fechado a equação numa só via. **Substrato**: a deliberação recruta o dlPFC (opções na memória de trabalho) e o cingulado anterior (monitoramento de conflito).

5. Exclusão mútua (XOR) — o ou exclusivo

$$x \oplus y \rightarrow \text{um exclui o outro}$$

Aqui as opções não podem coexistir: escolher uma *apaga* a outra. O XOR gera os impasses mais rígidos da clínica. **Substrato:** é um OU sob alarme — eixo HPA elevado e amígdala hiperativa estreitam o campo. Baixar o alarme converte um XOR travado de volta num OU deliberável.

6. Implicação (SE... ENTÃO...) — a regra condicional

$$x \rightarrow y \text{ (se } x, \text{ então } y)$$

A operação que constrói as crenças nucleares: “se eu fracassar, então não serei amado”. As cadeias de implicação são o material de que se faz o caráter. **Substrato:** aprendizado de contingências — estriado e circuitos dopaminérgicos codificam o “se-então”, o vmPFC armazena o valor esperado. Trata-la é oferecer experiência que contradiga o consequente: neuroplasticidade, não argumento.

Quadro-síntese das operações primárias

Operação	Notação	Função no afeto
Soma	$A = B + C$	Acumula a carga de experiências semelhantes; potencia o trauma.
NÃO	$\neg x$	Evita ou recusa a memória de desprazer (evitação, negação).
E	$x \wedge y$	Faz coexistir estados opostos sem contradição (amor e ódio).
OU	$x \vee y$	Mantém dois ramos abertos; base da deliberação e do dilema.
XOR	$x \oplus y$	Torna as alternativas excludentes; gera impasses rígidos.
Implicação	$x \rightarrow y$	Constrói crenças condicionais nucleares (se-então).

Parte IV — A gramática dos símbolos: como ler as fórmulas

Esta é a advertência de que depende toda a leitura correta. As fórmulas usam símbolos de três classes, e confundi-las gera a impressão — falsa — de que se está diante de aritmética a efetuar. Não se está.

(a) Operadores lógicos — $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow$ — agem sobre proposições de verdadeiro/falso, no sentido fiel à álgebra de Boole. São a camada binária fundante.

(b) Operadores de tendência — $\Sigma, \gg, >, \times, -$ — são qualitativos, não aritméticos. Σ “acumula”; $\gg$ “domina”; $\times$ “potencializa”; $-$ “é atenuado por”; $\rightarrow$ aqui é “leva a”, não implicação demonstrada.

(c) Funções nomeadas — $\text{peso}(\dots), \text{valor}(\dots), V(\dots), T(\dots), \text{posição}(\dots)$ — são rótulos de processos, não números. $\text{peso}(\text{outro})$ nomeia o quanto o outro entra no cálculo; não é quantidade medida.

A marca †. Quando aparece numa fórmula, sinaliza que a associação neurocientífica se apoia em inferência indireta — convergência por analogia de substrato, não medição direta. A marca viaja junto da fórmula para que a ressalva nunca se separe dela.

A regra de ouro. Quando uma linha mistura operadores lógicos e de tendência — como em $\text{Culpa} = \neg(\text{externo}) \times [\text{implicação}] + \Sigma \text{culpas}$ — **não** a leia como conta, e sim como frase: “a culpa recai sobre o eu na medida em que o externo é negado, a regra do orgulho opera, e as culpas anteriores se acumulam”. A fórmula condensa a frase; não a substitui por uma operação numérica. Por isso estes cálculos não têm “resultado” a calcular: têm uma estrutura a *ler*.

Parte V — Os vinte e um cálculos compostos

Cada cálculo é apresentado em três tempos — definição, decomposição nas operações primárias e, quando cabe, o manejo clínico. Os dezoito cálculos herdados da 2ª edição foram revistos e reagrupados, e três novos foram acrescentados para completar o sistema. Não são fórmulas a memorizar: são **estruturas a reconhecer no discurso do paciente**.

Grupo A — Cálculos da raiz: orgulho, culpa e sobrevivência

São os cálculos primordiais, ancorados no tronco e na amígdala. Tudo começa no **orgulho** — a necessidade primitiva de ter importância para ser aceito, lida pelo tronco como condição de sobrevivência.

Cálculo 1 — Orgulho e resistência

Definição. O inconsciente mede o nível de orgulho e dosa a resistência proporcional: quanto maior a necessidade de importância, maior a recusa a confrontar a realidade, o trauma ou a mudança.

Decomposição. uma implicação de base — se (perco importância) → (não sobrevivo) — alimentada pela soma de cada humilhação. A resistência é o NÃO aplicado a tudo que ameaça a autoimagem.

Cálculo 2 — Culpabilidade

Definição. O inconsciente atribui culpa — a si ou ao outro —, muitas vezes de forma irracional. No orgulhoso, todo desejo frustrado tende a virar culpa, e todo culpado “tem de pagar”, entrando em autopunição.

Decomposição. o exemplo canônico. Parte de “o sucesso só depende de mim” → (resultado é meu). Diante do fracasso, a ausência de um OU faz o NÃO zerar toda variável externa; sobra 100% para o eu, e a soma de culpas amplifica.

$$\text{Culpa(eu)} = \neg(\text{externo}) \times [\text{se (sucesso=meu)} \rightarrow (\text{fracasso=meu})] + \Sigma \text{culpas anteriores}$$

Manejo. não se discute a culpa — isso escuta com o pré-consciente. Reabre-se a equação: instala-se o OU que o orgulho suprimiu. A virtude é a humildade.

Cálculo 3 — Orgulho no sucesso e no fracasso

Definição. Variante focada no desempenho. O orgulho elevado calcula que só o sucesso é aceitável e o fracasso é ameaça à identidade — daí a busca obsessiva de aprovação e as defesas intensas na falha.

Decomposição. um XOR identitário — (sou sucesso) $\oplus$ (não tenho valor) — sobre o qual roda a implicação do fracasso.

Cálculo 4 — Temporalidade e neurose

Definição. O inconsciente é atemporal: uma cena de infância opera agora, com força presente. Por isso os traumas são revividos continuamente.

Decomposição. a soma de similaridades sem índice temporal — o cérebro identifica o traço comum e soma, sem perguntar “quando”.

Cálculo 5 — Neuroplasticidade e rigidez

Definição. O inconsciente calcula se o indivíduo está aberto ou resistente a novos aprendizados. Sem estímulo à mudança, o cérebro enrijece.

Decomposição. um NÃO aplicado à novidade ($\neg$ caos, $\neg$ aprendizado), reforçado pela soma de cada “mudança = perigo”.

Cálculo 6 — Os mecanismos de defesa

Definição. Todos os mecanismos de defesa são cálculos automáticos ativados pelo orgulho para proteger o ego da dor. A intensidade varia com o orgulho e a faixa. (Abertos um a um na Parte VIII.)

Decomposição. cada defesa é uma combinação das primárias: a projeção é $\neg$ (isto é meu) $\rightarrow$ (isto é do outro); a racionalização, uma implicação fabricada; a formação reativa, a inversão de sinal de um afeto; a dissociação, o NÃO levado ao limite.

Cálculo 7 — Transferência

Definição. A necessidade de repetir, relida como conta: o cérebro usa traços mnêmicos para identificar, numa figura do presente, padrões de uma figura do passado, e projeta sobre ela sentimentos não resolvidos. Tem muitos tipos (positiva, negativa, idealizadora, erotizada, de luto, narcísica, dependente, de controle, de saber), todos sob a mesma fórmula.

Decomposição. soma de similaridades aplicada a pessoas. A atemporalidade (Cálculo 4) permite tratar a figura atual como a antiga.

$$T(x) = F(falta) + M(semelhança\ com\ a\ figura)$$

Cálculo 8 — Escolha e rejeição de objetos afetivos

Definição. Com base na carência e no suprimimento da infância, o inconsciente calcula quem escolher e quem rejeitar, reproduzindo padrões de falta ou excesso de afeto parental.

Decomposição. uma implicação aprendida — se (tem o traço parental) $\rightarrow$ (preenche a falta) — sobre a soma das experiências afetivas primárias.

Cálculo 9 — Édipo e a sequência de filhos

Definição. O inconsciente dos pais escolhe um filho para representar suas expectativas. (Inteiramente reformulado na Parte do cálculo familiar.)

Decomposição. atribuição posicional por implicação + soma na fratria + reset modular a cada três.

Cálculo 10 — Superproteção e rejeição de filhos

Definição. Quando um filho nasce após a perda de outro, o inconsciente dos pais calcula a relação numa de três saídas: aceitar, rejeitar por culpa, ou superproteger.

Decomposição. um XOR de três ramos colapsado pela culpa (Cálculo 2).

Cálculo 11 — Necessidade de controle

Definição. Ligado ao orgulho, o inconsciente calcula que é preciso controlar tudo para garantir segurança e evitar humilhação — reflete-se em obsessão, burnout, TOC.

Decomposição. uma implicação de alarme — se (não controlo) $\rightarrow$ (sou humilhado)

— somada a cada descontrolo vivido como ameaça.

Cálculo 12 — Distanciamento emocional

Definição. Por orgulho, defesa ou trauma, o inconsciente calcula uma desconexão emocional como autoproteção.

Decomposição. é a dissociação cronicada: o NÃO levado da percepção até o afeto, somado a cada vínculo que doeu.

Cálculo 13 — Permissão

Definição. O cálculo descrito desde a origem como terapêutico. O trabalho clínico quebra barreiras para que o indivíduo perceba que tem permissão para agir, sentir e decidir fora dos padrões do superego.

Decomposição. a operação inversa da repressão: onde havia um NÃO, instala-se a afirmação; reabre-se um OU. É o protótipo de toda intervenção que destrava.

Grupo B — Cálculos que faltavam ao sistema

Seis cálculos acrescentados para fechar a arquitetura: o gatilho, o valor, a predição, a repetição, o pertencimento e o estado. São os que conectam o modelo à neurociência da decisão.

Cálculo 14 — Limiar de saliência (o gatilho)

Definição. Antes de qualquer cálculo de conteúdo, o cérebro decide se um estímulo merece processamento afetivo. Em quem somou muitas ameaças, o limiar baixa: estímulos neutros viram gatilhos.

Decomposição. implicação com limiar variável — se (saliência $> \theta$) $\rightarrow$ (aciona afeto) — onde θ cai com a soma de ameaças.

Cálculo 15 — Ponderação de valor (custo $\times$ recompensa)

Definição. Toda decisão afetiva pesa custo esperado contra recompensa esperada, antes de a consciência opinar. No orgulhoso, o custo de perder importância recebe peso desproporcional.

Decomposição. soma com sinais — os pesos vêm das implicações nucleares.

$$V = \Sigma(\text{recompensas}) - \Sigma(\text{custos})$$

Cálculo 16 — Erro de predição (a surpresa que ensina)

Definição. O cérebro prevê o que vem; quando o resultado difere, gera um erro de predição que atualiza a estrutura. O orgulho frequentemente bloqueia esse erro, descartando-o em vez de aprender.

Decomposição. um δ não nulo deveria atualizar a implicação nuclear; quando a defesa (NÃO) intercepta δ , a crença permanece. A clínica trabalha para deixar o δ chegar.

$$\delta = \text{resultado} - \text{previsão}$$

Cálculo 17 — Repetição (a tentativa de fechar a conta)

Definição. A compulsão a repetir é uma tentativa automática de resolver a memória mal fechada: o cérebro reapresenta o problema buscando a solução que

não veio.

Decomposição. soma de similaridades acoplada à solução automatizada — enquanto a equação da falta não fecha, o cérebro a recoloca.

Cálculo 18 — Pertencimento (dentro/fora do grupo)

Definição. A maior necessidade do inconsciente é a unidade com o grupo; o tronco lê isolamento como risco existencial. O cérebro calcula, em tempo real, se está “dentro” ou “fora”. É o pano de fundo do orgulho.

Decomposição. porta binária — $pertenço \in \{1, 0\}$ — com o estado 0 disparando o eixo HPA, sobre a soma de aceitações e rejeições.

Cálculo 19 — Regulação de estado (o tanque antes da lição)

Definição. Por trás de todos, há um cálculo permanente do estado corporal — alarme, cortisol, tônus do SARA. Decide se o cérebro está em condições de aprender ou apenas de sobreviver.

Decomposição. um portão sobre todos os demais — se (alarme alto) → (modo sobrevivência: prevalece o límbico). Baixar o alarme é abrir o portão.

Grupo C — Os cálculos do corpo (a decisão encarnada)

Damásio mostrou, contra Descartes, que não há decisão boa sem emoção: o corpo participa do cálculo de valor. Dois cálculos formalizam isso, e ambos estavam implícitos no Cálculo 15.

Cálculo 20 — O marcador somático (o pré-cálculo de valor)

Definição. Um cálculo de valor que antecede a deliberação, computado na alça entre o vmPFC e os mapas corporais (ínsula, córtices somatossensoriais). É a razão pela qual o indivíduo “sente” que algo está errado antes de saber dizer por quê — e pela qual a lesão do vmPFC produz pessoas que raciocinam bem e decidem mal.

Decomposição. é o que dá *peso* às variáveis do Cálculo 15 (ponderação de valor).

Cálculo 21 — O loop corporal (o corpo como rascunho)

Definição. Damásio situa, no tronco, um proto-self — a representação contínua do estado interno que é a base de toda consciência. É o fundamento neurocientífico do Cálculo 19 e do *fo* da hierarquia: o estado corporal não é um cálculo entre outros, é o solo sobre o qual todos os demais se erguem.

Decomposição. a urgência do tronco que a Virtologia atribui ao orgulho e ao egoísmo ancora-se aqui — não no modelo triúno (superado), mas na função homeostática do tronco.

Parte VI — A hierarquia em camadas: cálculos sobre cálculos

Os cálculos não estão soltos: organizam-se em **seis camadas**, cada uma operando sobre a saída da anterior. É a chave que transforma uma lista de operações num sistema — e é o que orienta a ordem da intervenção clínica.

Camada	O que calcula	Exemplos no capítulo
0 — Estado (f_0)	O portão corporal: decide se o sistema opera em modo “aprender” ou “sobreviver”.	Regulação de estado (Cálc. 19); proto-self, loop corporal (Cálc. 21)
1 — Primárias (f_1)	As portas lógicas e a soma: os operadores elementares do afeto.	Soma, NÃO, E, OU, XOR, implicação
2 — Redes (f_2)	Roteiam, mantêm e simulam a informação afetiva.	Saliência, Executiva, Modo Padrão (Parte VII)
3 — Defesas (f_3)	Protegem o ego combinando as primárias.	Os dezesseis mecanismos (Parte VIII)
4 — Orgulho / egoísmo (f_4)	Regulam a importância (SNO) e a prioridade (SNE) do self; a raiz familiar.	SNO, SNE, cálculo familiar
5 — Lei do Fluxo (f_5)	Integra tudo no potencial de realização da vida.	$PRF = E \times I \times PS \times FA \times PO \times LV$

$PRF = f_5(f_4(f_3(f_2(f_1(x)))))$, tudo condicionado por f_0 (estado)

Onde x é o estímulo que chega, f_1 são as operações primárias, f_2 as redes, e assim por diante até f_5 , a Lei do Fluxo. O f_0 — o estado corporal — não está *dentro* da cadeia: é a condição de possibilidade dela, o portão que decide se ela roda em modo “aprender” ou “sobreviver”. Por isso regular o estado vem **sempre** primeiro na clínica: sem abrir o portão, nenhuma camada superior opera bem.

A pleiotropia não enfraquece o modelo — ela o confirma

A objeção honesta é que os sítios cerebrais são pleiotrópicos: o estriado ventral, o vmPFC, a ínsula participam de quase tudo. Poderia parecer que isso dilui a tese de que cada cálculo tem substrato. A arquitetura em camadas mostra o contrário. Um operador de baixo nível — “somar similaridades”, “pesar valor” — *tem de* reaparecer em todo cálculo de alto nível que dele dependa, exatamente como o operador + reaparece em toda conta de aritmética sem que isso o torne vago. O estriado ventral está no orgulho, no vício e na escolha amorosa não por ser indistinto, mas porque os três *chamam a mesma sub-rotina de valor* que ele executa. O substrato compartilhado não dilui os cálculos: ele os aninha.

Parte VII — As três grandes redes como cálculo

Aqui está o coração do argumento neurocientífico: as redes de larga escala do cérebro — não apenas sítios isolados — são, elas próprias, cálculos sobre informação. Três redes concentram a vida mental, cada uma executando uma operação distinta. Formam a Camada 2: recebem as saídas das primárias e entregam material aos cálculos compostos. A neurociência as descreve como sistemas que se *alternam*; a Virtologia acrescenta que essa alternância é, ela mesma, um cálculo de arbitragem.

Rede de Saliência — o roteador

Ínsula anterior e cíngulo anterior. Decide, a cada instante, qual informação merece processamento e para qual sistema enviá-la — é a execução do Cálculo 14 (limiar) em escala de rede: se $\text{relevância}(x) > \theta \rightarrow \text{encaminha}(x)$. Seu papel maior é *chavear* entre as outras duas: quando algo externo se torna saliente, ativa a Executiva e desativa a DMN; quando o mundo aquietta, faz o inverso.

Rede Executiva Central — a mesa de trabalho

dIPFC e parietal. Mantém informação ativa, compara alternativas, inibe respostas automáticas e dirige a ação orientada a metas — executa o OU vivo (Cálculo 4) e a inibição.

Executiva = manter(opções) $\wedge$ inibir(automático) $\wedge$ dirigir(meta)

É a base biológica do ego forte como gestor: onde a Executiva governa, o comando está no lobo frontal.

Rede de Modo Padrão (DMN) — o simulador

Córtex pré-frontal medial, cíngulo posterior/precúneo, lobo temporal medial. Ativa-se quando o cérebro *não* está focado no mundo externo: gera o pensamento autorreferente, evoca o passado, imagina o futuro, constrói a narrativa do eu e modela a mente dos outros — executa a soma de similaridades aplicada ao self e a fabricação do futuro que a Lei do Fluxo descreve.

DMN = simular(self, passado, futuro, outro)

É, ao mesmo tempo, a fonte da imaginação criativa e do ruído da ruminação.

O cálculo acima das três: a arbitragem de rede

O ponto decisivo é que a *alternância* entre as redes é, ela própria, um cálculo, arbitrado pela Saliência. A saúde mental, lida por aqui, é a **flexibilidade** dessa arbitragem: entrar na DMN para imaginar e descansar, sair dela para agir, voltar quando convém. A patologia é o travamento.

Saúde = flexibilidade(Saliência $\rightleftharpoons$ {Executiva, DMN})

Travamento	Cálculo	Quadro associado
Preso na DMN	DMN não cede à Executiva	Ruminação depressiva, ansiedade autorreferente
Executiva sem freio	Não retorna ao simulador	Rigidez, dificuldade de descanso e de empatia

A virtude como religação da arbitragem. Práticas contemplativas (atenção plena), na leitura virtológica, são treino direto desta arbitragem: aprende-se a observar a DMN sem ser arrastado por ela e a chavear conscientemente para o presente — exatamente o que a Lei do Fluxo chama de “habitar o presente”. Treinar a virtude é treinar o roteador.

Nota de evidência (†). As três redes estão entre os sistemas de larga escala mais replicados da neurociência, e a função de chaveamento da Saliência sobre DMN e Executiva tem suporte que vai além da correlação (TMS e modelos causais dinâmicos; Menon; Sridharan; Chen et al., 2013). O que é leitura virtológica — e não achado — é a interpretação desse chaveamento como “cálculo de arbitragem a serviço da virtude”. A função é apoiada; o sentido virtológico é a camada interpretativa. A Virtologia não reivindica ter descoberto uma rede nova: relê redes conhecidas como operações.

Parte VIII — Os mecanismos de defesa como cálculos

O Cálculo 6 reuniu todas as defesas sob uma operação geral: combinações de NÃO, implicação e inversão de sinal, ativadas pelo orgulho para proteger o ego da dor. Aqui abrimos o inventário — alinhado à tradição que vai de Anna Freud a Zimerman. Não são dezesseis nomes a decorar: são **dezesseis operações distintas sobre a memória afetiva**. Todas compartilham o núcleo defensivo (Camada 3, a serviço do orgulho da Camada 4); a diferença está na operação que cada uma aplica.

Grupo I — Defesas da recusa (operam com NÃO)

Aplicam um NÃO a alvos diferentes.

- **Repressão.** Expulsar da consciência um conteúdo de desprazer, mantendo-o ativo — o NÃO aplicado ao acesso, não ao conteúdo: $\neg \text{acesso(memória)} \wedge \text{manter(ativa)}$. Continua somando e pressionando; por isso retorna.
- **Negação.** Recusar reconhecer uma realidade externa dolorosa — o NÃO sobre a percepção do fato: $\neg \text{reconhecer(realidade)}$. Barra a entrada do real (a repressão barra a memória interna).
- **Dissociação.** O NÃO levado ao limite: desconectar-se da própria experiência — $\neg \text{conexão(eu, experiência)}$. Defesa dos estados de trauma agudo.

Grupo II — Defesas do deslocamento (movem o alvo ou o sinal)

- **Projeção.** Atribuir ao outro um conteúdo próprio inaceitável — $\neg(\text{isto é meu}) \rightarrow (\text{isto é do outro})$.
- **Deslocamento.** Redirecionar um afeto do alvo verdadeiro (perigoso) para um substituto (seguro): $\text{afeto(alvo_real)} \rightarrow \text{alvo_seguro}$. A carga se mantém; o alvo troca.
- **Formação reativa.** Converter um afeto inaceitável no seu oposto exato — a inversão de sinal: $(-x) \rightarrow (+x \text{ exibido})$. O exagero denuncia a operação.
- **Sublimação.** A defesa madura: redirecionar a energia de um impulso para um fim socialmente valioso, mantendo a carga e elevando o alvo: $\text{energia(impulso)} \rightarrow \text{alvo_valioso}$.

Grupo III — Defesas do tempo e da idade (regridem ou desfazem)

- **Regressão.** Recuar a um funcionamento de fase anterior sob estresse — um retrocesso de faixa: $\text{funcionamento(fase_n)} \rightarrow \text{funcionamento(fase_n-k)}$.
- **Anulação (desfazer).** Cancelar um ato ou pensamento com um ato simétrico inverso: $\text{ato} + \text{ato}^{-1} \rightarrow (\text{tenta}) 0$. Motor de muitos rituais obsessivos.

Grupo IV — Defesas da abstração (substituem afeto por ideia)

- **Intellectualização.** Substituir a vivência afetiva por sua análise abstrata: $\text{afeto} \rightarrow \text{conceito(sem carga)}$.
- **Racionalização.** Fabricar uma justificativa lógica para uma causa inaceitável — uma implicação sob medida: $\text{fabricar[causa_aceitável} \rightarrow \text{resultado]}$.

Grupo V — Defesas da identidade (operam sobre o limite eu-outro)

- **Identificação.** Incorporar traços de outra pessoa para fortalecer o eu: $\text{self} += \text{traços}(\text{outro})$. Saudável (modelo) ou defensiva (com o agressor).
- **Desidentificação.** O inverso — subtrair do self um traço para se diferenciar: $\text{self} -= \text{traço}(\text{rejeitado})$.
- **Identificação projetiva.** Projetar no outro um conteúdo próprio e induzi-lo a encarná-lo (Klein, Bion): $\text{projeção}(\text{conteúdo}) \wedge \text{induzir}(\text{outro})$.
- **Compensação.** Contrabalançar uma fraqueza com a hipertrofia de outra área: $\neg \text{suficiência}(\text{A}) \rightarrow \text{reforço}(\text{B})$.

Parte IX — Os transtornos como cálculos do inconsciente operacional

A leitura calculatória permite descrever grandes quadros como **padrões de cálculo** — não como sua causa única, que é heterogênea e ainda debatida, mas como a operação que diferentes substratos podem produzir. Cada fórmula abaixo é uma frase clínica que orienta onde intervir.

Cálculo — — Depressão

Definição. O cálculo de valor travado em “tudo é perda”: o Cálculo 15 preso num viés negativo global — o cérebro atribui sinal negativo a quase toda opção e a quase todo futuro, enquanto a Executiva, rebaixada, não reabre alternativas e a DMN alimenta a ruminação.

$$\text{Depressão} = [V(\text{quase tudo}) \rightarrow \text{negativo}] \wedge \neg(\text{Executiva reabre}) \wedge \text{DMN}(\text{ruminação})$$

Cálculo — — Transtorno bipolar

Definição. Se a depressão é o valor preso no negativo, a mania é o mesmo cálculo com o ganho disparado para o positivo: recompensa superestimada, custo subestimado, ação desinibida. Lê-se o bipolar como a oscilação extrema do ganho — metáfora calculatória, não mecanismo.

$$\text{Mania} = V \text{ superestima recompensa} \wedge \neg \text{inibição(Executiva)} ; \text{Bipolar} = \text{oscilação(ganho)}$$

Cálculo — — Ansiedade e pânico

Definição. O Cálculo 14 (limiar de saliência) com θ no chão e a amígdala disparando: sinais corporais neutros (um batimento, uma tontura) são roteados como ameaça de morte, e o loop “como se” (Cálculo 21) amplifica a catástrofe antecipada.

$$\text{Pânico} = [\text{saliência(sinal neutro)} > \theta_{\text{baixo}}] \rightarrow \text{amígdala} \rightarrow \text{loop catastrófico}$$

Cálculo — — TEPT

Definição. A forma mais pura da soma de similaridades (Cálculo 1) combinada à atemporalidade (Cálculo 4): a memória traumática não extingue — cada gatilho a reabastece com força plena, e o frontal não consegue contextualizá-la como passada.

$$\text{TEPT} = \Sigma(\text{trauma}) \text{ sem extinção} \wedge \text{atemporalidade} \wedge \neg(\text{contextualização frontal})$$

Cálculo — — TOC

Definição. A alça córtico-estriato-talâmica gera um sinal persistente de “algo está errado” que o ritual tenta zerar e não consegue — porque o erro de predição (Cálculo 16) não recebe o sinal de “resolvido”. A anulação (defesa) é o motor: ato + inverso, em loop.

$$\text{TOC} = \text{sinal_de_erro persistente} \wedge [\text{ato} + \text{ato}^{-1} \rightarrow \neg 0] \wedge \text{repetição}$$

Cálculo — — Dependência

Definição. A dopamina codifica a predição de recompensa, não só o prazer

(Schultz; Kandel). O vício sequestra esse cálculo: a droga inunda o estriado, e as pistas que a predizem disparam um desejo que se sobrepõe a todo custo futuro e a todo peso do outro (cruzando o SNE).

Vício = predição(recompensa) sequestrada $\wedge$ [recompensa_imediata $\gg \Sigma(\text{custos} + \text{outro})$]

Cálculo — — Psicopatia

Definição. O caso extremo e estrutural do egoísmo (Kiehl): há redução de substância cinzenta em todo o circuito paralímbico, e o peso do outro no cálculo de valor tende a zero — não por escolha, mas por déficit do hardware que normalmente o computa. Medo e culpa não geram sinal.

Psicopatia = peso(outro) $\rightarrow$ 0 (estrutural) $\wedge \neg(\text{sinal de medo/culpa}) \wedge$ valor próprio intacto

Parte X — Orgulho e egoísmo, em síntese

Os dois grandes sistemas da Camada 4 são cálculos compostos de larga escala, cada um com sua própria Parte no capítulo. Para a aula, retêm-se os núcleos.

SNO — Sistema Neurofuncional do Orgulho

Regula a **importância** do self diante do grupo. O núcleo é comparativo: o sinal de recompensa não vem do ganho absoluto, mas do *ranking* — subir de posto dispara, descer dói. A humildade virtológica é o desligamento treinado deste cálculo: derivar valor de outra coisa que não a posição. Suas seis famílias vão da exibição do valor à arrogância moral, reguladas transversalmente pela maior ou menor inibição do dlPFC (muito controle *disfarça* o orgulho; pouco controle o *exibe*).

SNE — Sistema Neurofuncional do Egoísmo

Regula a **prioridade** do self na partilha de recursos — o meu antes do seu. É a arbitragem self-outro resolvida, a cada situação, em favor do próprio:

Egoísmo = arbitragem(self, outro) → self ; peso(outro) → baixo

Suas famílias vão da agressividade e da adicção à indiferença afetiva, à inflexibilidade e à transgressão — todas legíveis como o rebaixamento do peso do outro no cálculo de valor, normalmente contido de cima para baixo pelo controle pré-frontal.

Parte XI — A leitura clínica em camadas

A arquitetura fornece um **protocolo de escuta**. Diante de qualquer quadro, percorre-se de baixo para cima — porque uma camada inferior travada impede a leitura das superiores.

Camada 0 — primeiro. O estado está regulado? Em alarme, nada acima opera. Regula-se antes de tudo.

Camadas 2-3. Qual rede está travada (ruminação na DMN? limiar baixo na Saliência?) e qual defesa está em ato (qual das cinco assinaturas de grupo)?

Camada 4. Qual sistema domina — orgulho (posição) ou egoísmo (peso do outro)? Qual a raiz familiar (escolhido, aliado, excluído)?

Camada 5. Qual fator da Lei do Fluxo colapsou e está puxando os outros para baixo?

O princípio terapêutico que atravessa todas as camadas: **não se interpreta a dor — reabre-se a equação**. Onde o orgulho fechou um OU num XOR, reinstala-se a alternativa; onde a defesa interceptou o erro de predição, deixa-se o δ chegar; onde a soma de similaridades sustenta a transferência, distingue-se a figura atual da antiga. A virtude, nessa leitura, é a reorganização treinada do cálculo de valor.

Parte XII — Fronteira epistêmica

Uma aula de pós-graduação exige explicitar o estatuto do que se ensina. Três fronteiras valem para todo o modelo, com igual peso para todas as suas partes — orgulho e egoísmo, mas também família, dinheiro, transtornos e crime. Nenhuma parte goza de estatuto mais firme por ser mais antiga ou mais desenvolvida.

- **As fórmulas são notação clínica**, uma linguagem para ler a estrutura e dirigir a intervenção — não equações físicas com grandezas medidas. Organizam e dirigem; não medem.
- **Os sítios cerebrais são associações heurísticas** amparadas na literatura, pleiotrópicas, não reduções de um-para-um. A pleiotropia torna o aninhamento plausível, não provado.
- **O coração terapêutico — a tradução das virtudes em reorganização do cálculo de valor** — é hipótese amparada por analogia com a literatura de plasticidade por treino, pendente de demonstração longitudinal direta.

É justamente por ser **falsificável e ainda não fechada** que a tese é fértil: ela diz onde olhar, o que medir e como saber se está errada. Descrever o inconsciente como cálculo é, antes de tudo, tornar a clínica da alma uma disciplina que se pode testar. A título de exemplo de teste: a tese do egoísmo prediz que todos os seus subcomportamentos, sob contraste self vs. outro, convergiriam para o núcleo de arbitragem (vmPFC/dmPFC) com déficit de modulação da TPJ — e seria refutada se não convergissem.

Síntese — o que levar desta aula

- **O inconsciente não guarda símbolos; ele opera.** Tudo o que é automático no cérebro é cálculo sobre prazer e desprazer.
- **Dois níveis:** seis operações primárias (soma + portas lógicas) compõem todos os cálculos compostos.
- **As fórmulas são frases, não contas.** Lê-se a estrutura; não se efetua aritmética. A marca † guarda a ressalva de evidência.
- **Vinte e um cálculos** cobrem a raiz (orgulho, culpa), o gatilho, o valor, a predição, a repetição, o pertencimento, o estado e o corpo.
- **Seis camadas** organizam tudo, do estado (f_0) à Lei do Fluxo (f_5); a pleiotropia dos sítios é o sinal do aninhamento.
- **Três redes** (Saliência, Executiva, DMN) são cálculos; a saúde é a flexibilidade da arbitragem entre elas — e a virtude a treina.
- **Defesas e transtornos** têm assinatura calculatória; a clínica reabre a equação em vez de interpretar a dor.
- **O modelo é falsificável** — e é isso que o torna uma disciplina, não uma doutrina.

Questões para discussão

- Por que a distinção entre operadores lógicos e operadores de tendência é decisiva para *não* transformar a clínica numa pseudomatemática? Traga um exemplo de leitura errada.
- Tome o Cálculo 2 (culpabilidade). Mostre, na fala de um paciente, onde está o NÃO que zera o externo e como você reinstalaria o OU.
- Explique por que regular o estado (Camada 0) precede qualquer interpretação. O que muda na conduta quando o portão fo está fechado?
- Escolha um transtorno e reescreva sua fórmula identificando qual camada e qual rede estão travadas. Que intervenção cada travamento sugere?
- Em que sentido a pleiotropia dos sítios cerebrais *fortalece*, e não enfraquece, a tese do aninhamento? Onde está o limite dessa defesa?

Vinheta clínica para a aula

“Meu chefe não respondeu meu e-mail há dois dias. Já sei que ele me acha incompetente, que vão me demitir; passei a noite ensaiando o que vai dar errado. Não consigo pedir feedback — se eu perguntar, confirmo que sou um problema.”

Exercício. Identifique: (a) o limiar de saliência baixo (Cálc. 14) que transforma o silêncio neutro em ameaça; (b) a DMN em ruminação simulando catástrofes futuras (Camada 2); (c) a implicação nuclear se (peço) → (confirmo o defeito) que fecha o OU (Cálc. 13, permissão, invertido); (d) o orgulho que lê a possível avaliação como risco à posição (Camada 4). Proponha a sequência de intervenção camada a camada.

Referências essenciais

Entradas em formato de trabalho; consolidar na bibliografia do curso, no padrão ABNT.

CASAROTTO, E. Fundamentos da Virtologia. 3. ed. — capítulos O Inconsciente Operacional e Mecanismos de Defesa; artigos do SNO e do SNE; Dicionário Neurocientífico da Virtologia. FREUD, A. O ego e os mecanismos de defesa (1936). DAMÁSIO, A. O erro de Descartes; A sensação do que acontece. KANDEL, E. R. Princípios de Neurociência; Em busca da memória. OCHSNER, K.; GROSS, J. The cognitive control of emotion (2005). MENON, V.; SRIDHARAN, D. et al. Saliency network and network switching. CHEN, A. et al. Causal interactions between large-scale networks (2013). MONCRIEFF, J. et al. The serotonin theory of depression (2022). KIEHL, K. The psychopath whisperer.

O inconsciente não é um enigma a decifrar. É uma conta a ler — e, lida, a recalcular.

— Dr. Eduardo Casarotto

A Consciência

O estado de consciência e a Consciência — o que o cérebro faz e o que o cérebro toca

Dr. Eduardo Casarotto · Instituto Virtudes

“Há o que o cérebro faz, e há o que o cérebro toca. Confundir os dois é a origem de quase toda a confusão sobre a mente.”

Dr. Eduardo Casarotto

Enquadramento da aula

Há, no uso corrente da palavra *consciência*, uma ambiguidade que atravessa a filosofia, a religião e a neurociência há séculos. Quando o médico diz que um paciente “recuperou a consciência”, fala de uma coisa. Quando o contemplativo diz que alcançou “um estado superior de consciência”, fala de outra. Essas duas coisas costumam ser tratadas como uma só — e não são. Esta aula separa-as com rigor, porque a separação é a chave de tudo o que a Virtologia tem a dizer sobre o tema.

De um lado está o que chamamos de **estado de consciência**: um fenômeno cerebral, neurológico, mensurável. Aqui o terreno é o da neurociência, e nele a Virtologia não inventa nada — descreve o que a ciência já descreve e caminha lado a lado com Damásio, Chalmers, Nagel, Kandel. De outro lado está o que chamamos, com letra maiúscula, de **Consciência**: a afirmação de fundo da obra de que a Consciência está **fora do cérebro**, é a alma, e o cérebro apenas a acessa. São duas coisas de naturezas diferentes — e é justamente por isso que não competem nem se refutam.

Uma palavra sobre método. Onde a Virtologia faz afirmação neurológica — o estado de consciência, o inconsciente operacional —, presta contas à neurociência e está fundamentada; ali nada se inventa. Onde afirma a Consciência — que está fora do cérebro e é a alma —, faz afirmação de outra natureza, ontológica, que a neuroquímica não mede nem refuta, porque seu objeto não é neural. Ciência onde é ciência; tese assumida onde é tese. É essa honestidade de planos que torna o tema defensável.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, o pós-graduando deverá ser capaz de:

- distinguir com rigor **estado de consciência** (cerebral) e **Consciência** (a alma), e explicar por que confundi-los é um erro de categoria;
- descrever as **áreas do cérebro** implicadas — o SARA e o sistema de arousal, o tronco, o tálamo, a ínsula, o hipocampo, o córtex pré-frontal e as três grandes redes;

- expor os **tipos de consciência**: a cadeia de Damásio (do proto-self à consciência moral), os três estados do ego e o continuum das Faixas;
- situar o **limite que a própria neurociência reconhece** (problema difícil, o morcego de Nagel) sem transformá-lo indevidamente em prova metafísica;
- explicar a **tese ontológica** da Consciência como alma, a metáfora da internet, e a ponte que liga os dois planos — a estruturação do ego pelas virtudes.

Roteiro

Parte I — Duas palavras numa só. Parte II — O estado de consciência (neurociência): o SARA e o arousal, a cadeia de Damásio, o oposto do inconsciente operacional, o limite da ciência. Parte III — Os três estados do ego (os tipos de consciência) e suas funções. Parte IV — A Consciência: a alma fora do cérebro. Parte V — A única ponte. Parte VI — As faixas da Consciência. Parte VII — As duas, lado a lado. Parte VIII — Método e fronteira epistêmica. Síntese, discussão e referências.

Parte I — O problema: duas palavras numa só

A confusão histórica sobre a mente nasce de usar uma única palavra para dois objetos de naturezas distintas. O médico que fala em “recuperar a consciência” refere-se a um **estado do cérebro** — vigília, atenção, o saber-que-se-sabe. O místico que fala em “elevar a consciência” refere-se a algo que a Virtologia entende como **contato com a alma**. O primeiro é medível; o segundo é de outra ordem. Tratá-los como sinônimos é a origem de quase todo o mal-entendido — e separá-los é a primeira tarefa desta aula.

Dois territórios, duas naturezas

O estado de consciência é matéria de neurociência: cerebral, mensurável, e nele concordamos com a ciência. A Consciência está fora do cérebro: é a alma, de outra ordem que o neural, e a neuroquímica não a alcança nem a refuta, porque é de outra natureza. Exigir que a alma apareça no tecido neural, ou tratar a Consciência como mais um circuito, é erro de categoria. Mantêm-se os dois planos separados de propósito.

Parte II — O estado de consciência (Território da Neurociência)

Começamos pelo terreno firme, onde há medição, substrato e consenso. Tudo o que os neurocientistas estudam sob o nome de “consciência” — vigília, atenção, integração da informação, o saber-que-se-sabe — é o que a Virtologia chama de **estado de consciência**, reservando a palavra “Consciência”, sem qualificativo, para a segunda parte. Aqui caminhamos com a ciência.

§1. Um regime do cérebro, não uma substância

O estado de consciência não é uma coisa nem um lugar — é um **regime de funcionamento** do cérebro. Tem componentes distinguíveis, e a confusão popular nasce de tratá-los como indistintos. Convém, portanto, nomear as áreas do cérebro que o sustentam antes de descrever seus graus.

§2. As áreas do cérebro: o arousal e o SARA

Na base de tudo está o **arousal** — o nível global de ativação do encéfalo, que decide se o córtex está em vigília alerta, sonolência, sono ou anestesia. Ele depende do **sistema ativador reticular ascendente (SARA)**: projeções que sobem de núcleos do tronco cerebral (formação reticular; sistemas noradrenérgico, colinérgico, serotoninérgico, dopaminérgico e histaminérgico) para o **tálamo** e o **córtex**. Funcionalmente, esse sistema “liga” o córtex, dessincroniza o EEG (ondas rápidas de baixa voltagem) e torna possível que qualquer conteúdo consciente — sensação, memória, pensamento — apareça. Sem um mínimo de arousal, não há experiência de conteúdo algum; com arousal excessivo, o sistema entra em hiperativação, ansiedade e desorganização.

Mas o SARA faz mais do que manter-nos acordados: ele é o **porteiro da consciência**. Como quase tudo o que chega ao cérebro é descartado, alguém precisa decidir o que entra — e essa é a *primeira unidade funcional* de Luria, aquela que sustenta o estado de alerta sem o qual nenhuma outra função opera. O SARA trabalha por marcação de relevância, numa economia simples: **alta prioridade exige baixo esforço; baixa prioridade exige grande esforço**. O que toca a sobrevivência passa sem custo; o que é emocionalmente carregado tem prioridade intermediária; o conhecimento novo e abstrato — justamente o que se quer ensinar — tem baixa prioridade natural e exige o maior esforço para atravessar o portão.

Como se convence o porteiro: as três alavancas

Atenção. O foco consciente é a ordem direta ao porteiro — isto importa, deixe entrar. É modulada de cima para baixo pelo córtex pré-frontal, que reforça ou silencia o que o SARA deixa passar.

Emoção. Conteúdo emocionalmente carregado salta a fila — por isso se trabalha o sentido e a vivência afetiva, não só a definição fria.

Repetição multimodal. A mesma mensagem por múltiplos canais, repetidamente, gera redundância: o porteiro recebe o sinal por tantas vias que o classifica como

relevante. É a forma mais robusta de consolidação — e o sistema auditivo, que não desliga, é um de seus principais alimentadores.

§3. Vigília não é consciência

O primeiro componente do estado de consciência é a **vigília** — estar acordado, com o cérebro ativado o suficiente para gerar fenômenos mentais. É regulada pelo SARA, no tronco encefálico. Mas a vigília, sozinha, não basta: um paciente em estado vegetativo pode ter olhos abertos e ciclo sono-vigília preservado sem que haja qualquer experiência de um “eu”. A vigília é condição **necessária, não suficiente** — é preciso a integração que constrói um sujeito da experiência.

§4. A cadeia de Damásio: do proto-self à consciência moral

É aqui que António Damásio oferece o mapa que a Virtologia adota como base científica do estado de consciência. Em *O Sentimento de Si* e *O Mistério da Consciência*, Damásio descreve a consciência não como fenômeno etéreo, mas como processo biológico enraizado na interação contínua entre cérebro e corpo, e a desdobra numa cadeia de precedências — cinco degraus, cada um possibilitando o seguinte:

- **Proto-self.** Os mapas corporais básicos e a homeostase, ancorados no tronco cerebral, no hipotálamo e na ínsula. Acompanha o domínio do inconsciente operacional nas faixas Primitiva e Sensação.
- **Self central (e consciência central).** A sensação efêmera do “eu que vive isto agora”. Acompanha o ego reativo em consciência parcial.
- **Self autobiográfico.** Integra memória e projeção numa narrativa de identidade — ancorado no hipocampo, no córtex pré-frontal e no cíngulo posterior. Acompanha o ego que constrói quem é.
- **Consciência ampliada.** A vida mental que se estende no tempo, para além do instante presente. Acompanha o ego forte das faixas mais altas.
- **Consciência moral.** O degrau superior, ancorado no córtex pré-frontal ventromedial. É onde a experiência integrada se torna juízo ético.

São paralelos, não identidades — os construtos virtológicos são definidos por dentro. E convém notar: Damásio é, ele próprio, **anti-dualista** — para ele a consciência é função do organismo, e a Virtologia não o contradiz *aqui*, no estado de consciência, onde também tratamos de função do organismo. A divergência, se há, não está neste plano; está no que a segunda parte chama de Consciência, que é outro objeto.

§5. O estado de consciência é o oposto do inconsciente operacional

Reunindo os fios: o estado de consciência, na Virtologia, é **o grau de domínio do ego sobre os mecanismos cerebrais automáticos**. Não é interruptor de duas posições, mas um **continuum** — exatamente o dos três estados do ego. No ego inconsciente, a Rede de Modo Padrão entra em laço com a Rede de Saliência, o proto-self está desregulado, e dominam o vício, a compulsão e o ato impulsivo. No ego subconsciente, a Saliência treina a pausa do instinto para ceder o comando à

Rede Executiva. No ego consciente, a turbulência cessa e o self autobiográfico orchestra com serenidade a cooperação entre as três redes.

A revelação — a **Pedra de Rosetta** da Virtologia — é que alcançar o topo **não exige um cérebro novo**: a biologia é a mesma; o que muda é o regime de cooperação entre as mesmas redes e os mesmos mapas do corpo.

§6. O limite que a própria neurociência reconhece

Há um ponto, dentro da ciência da consciência, em que os próprios pesquisadores reconhecem que a descrição funcional não fecha a questão — e é importante apresentá-lo como **limite da neurociência**, não ainda como porta para a Virtologia. A Teoria do Espaço de Trabalho Global, de Bernard Baars, descreve com engenho *como* a informação se torna globalmente disponível no cérebro — excelente descrição do mecanismo. Mas note-se o que explica: o acesso, a integração, a função.

David Chalmers nomeou o que essas descrições não alcançam: o **problema difícil da consciência** — por que há experiência subjetiva, e não apenas processamento no escuro. Nenhuma descrição funcional, por completa, transforma automaticamente função em *sentir*. Thomas Nagel mostrou o mesmo abismo no clássico “Como é ser um morcego?": o caráter subjetivo da experiência escapa, por princípio, à descrição objetiva. E Penrose e Hameroff arriscaram mais, propondo processos físicos que a neuroquímica clássica não esgotaria — modelo especulativo e contestado, registrado não como verdade, mas como sinal de que o problema segue aberto mesmo na ciência dura.

O estatuto exato deste ponto. *Chalmers, Nagel e Penrose não provam a tese da Virtologia — e não os invocamos como prova. O que estabelecem é mais modesto e mais sólido: que a descrição neurobiológica do estado de consciência, por avançada, reconhece o seu próprio limite. Esse limite não é, por si, um argumento a favor da alma; é o reconhecimento honesto de que o ser humano não se deixa esgotar pela função. É nele — e só depois dele — que a segunda parte abre o seu terreno.*

Parte III — Os três estados do ego: os tipos de consciência

Diferentemente de Freud, para quem inconsciente, pré-consciente e consciente são *sistemas* com conteúdos próprios, e diferentemente de Jung, na Virtologia o consciente e o inconsciente não são *lugares* da mente, mas **estados de um mesmo ego**. É o mesmo ego que, conforme seu grau de estrutura e o estado químico do aparelho, ora opera de forma inconsciente, ora subconsciente, ora consciente. A diferença não é topográfica; é um regime de funcionamento neural.

A base neurocientífica: três redes, um porteiro, três selves

A passagem do ego inconsciente ao consciente corresponde a uma mudança de predominância entre sistemas cerebrais — na moldura evolutiva do cérebro triúno de MacLean (moldura heurística, não anatomia literal): do domínio do tronco e do sistema límbico ao domínio do córtex pré-frontal. Em termos de redes, Vinod Menon descreveu três sistemas de larga escala: a **Rede de Modo Padrão** (repouso e autorreferência), a **Rede Executiva Central** (controle deliberado) e a **Rede de Saliência** (ancorada na ínsula anterior), que funciona como comutador, decidindo a cada instante qual das outras assume o comando. Antes de tudo, o SARA regula o estado de alerta. A Virtologia lê os três estados do ego como configurações dinâmicas dessas redes, articuladas aos três selves de Damásio.

A imagem da montanha

- **Ego inconsciente — a base.** Manda a reatividade: um fluxo turbulento de respostas automáticas em que o passado se mistura ao presente e o sujeito revive traumas como se fossem hoje. Neurologicamente, é a Rede de Modo Padrão presa num laço com a Saliência, amplificando o medo, sobre um proto-self corporal desregulado. Dominam o vício, a compulsão, o apagão, o ato impulsivo.
- **Ego subconsciente — a encosta.** Um campo de batalha interna: ora o instinto fala mais alto, ora a reflexão vence. Tenso, porém produtivo. É o puro treinamento da Saliência tentando pausar os instintos para ceder o comando à Executiva. Estado típico da Consciência Parcial, em que o sujeito percebe mais do que consegue reagir.
- **Ego consciente — o topo.** A turbulência cessa e entra em cena uma orquestração serena, com as ações alinhadas às virtudes. Nada de mágico: é o self autobiográfico integrado orquestrando de forma fluida a cooperação entre as três redes. Alcançar esse estado não exige um cérebro novo — muda o regime de cooperação.

Estado do ego	Regime neural (Menon / Damásio)	Experiência subjetiva
Inconsciente	DMN em laço com a Saliência; proto-self desregulado	Reatividade; trauma revivido como presente
Subconsciente	Saliência treinando a pausa do instinto	Batalha interna; percebe mais do que reage
Consciente	Self autobiográfico orquestrando as três redes	Serenidade; ação alinhada à virtude

§ As funções do ego no estado inconsciente

No estado inconsciente, o ego não governa o sistema — é governado. A vida psíquica, o comportamento e o sintoma são respostas de um aparelho dominado pela falta, pelo orgulho e pelos automatismos do inconsciente operacional. Dezoito funções o caracterizam:

- **Atemporalidade** — reage como se eventos passados ocorressem no presente, sem distinção entre antes e agora.
- **Mecanismos de defesa** — negação, projeção, repressão, racionalização, formação reativa e sublimação operam automaticamente, distorcendo a realidade.
- **Transferência** — padrões aprendidos com figuras do passado são projetados em pessoas do presente, sem percepção da origem.
- **Ausência de contradição lógica** — ideias opostas coexistem sem conflito, gerando comportamentos paradoxais.
- **Persona rígida (couraça de caráter)** — a máscara torna-se automática, usada para sobreviver socialmente, sem consciência de sua artificialidade.
- **Predomínio do simbólico** — interpreta o mundo numa chave simbólica, projetando conteúdos internos sem perceber.
- **Actings (atos impulsivos)** — ações sem reflexão, descarga direta de tensões, seguidas de culpa ou negação.
- **Temperamento dominando o ego** — traços herdados comandam o comportamento, porque o ego não tem força para regulá-los.
- **Superego automático** — rígido e punitivo, gera culpa desproporcional, autocensura e autopunição.
- **Condicionamentos (clássicos e operantes)** — padrões por reforço e punição executados como fórmulas, sem juízo.
- **Priming** — estímulos prévios pré-ativam redes associativas; é a preparação do sistema, não ainda a reação.
- **Gatilhos** — um estímulo semelhante a experiências somadas como ameaça aciona, de forma abrupta, a resposta gravada.
- **Desejo bruto** — impulso de preencher a falta de unidade por objetos, pessoas, poder ou sensação, sem elaboração.
- **Necessidade primitiva de aceitação** — a falta é vivida como ameaça de rejeição; persegue-se aprovação obsessivamente.
- **Culpa ilógica e autopunição** — culpa desproporcional leva à autossabotagem, reforçando ciclos de sofrimento.
- **Distorção da realidade** — a percepção é filtrada por defesas, traumas e orgulho: interpretações paranoides, catastróficas ou idealizadas.

- **Distorção da imagem corporal** — a percepção do próprio corpo é alterada por memórias, comparação e culpa.
- **Distorção da comunicação** — agressividade passiva, omissões e projeções dificultam a expressão autêntica e a escuta real.

§ As funções do ego no estado subconsciente

O estado subconsciente é o meio do caminho — campo de batalha entre os automatismos e as possibilidades da consciência. É nele que o trabalho terapêutico encontra terreno fértil: o sujeito já percebe parcialmente, já pode pausar. Nove funções o caracterizam:

- **Percepção parcial do Self** — noção inicial de quem é, mas autoimagem instável e dependente de aprovação.
- **Percepção parcial do próprio corpo** — percebem-se tensões e estados internos, com dificuldade de regulá-los.
- **Percepção parcial do outro e da realidade** — menos distorção que no estado inconsciente, mas ainda projeções por medo e orgulho.
- **Domínio parcial do foco atencional** — já consegue, em parte, escolher onde colocar a atenção.
- **Decisão parcialmente consciente** — consideram-se consequências e valores, mas ainda se cede ao impulso e ao controle.
- **Empatia inicial e oscilante** — emerge de modo intermitente, alternando com autodefesa e competição.
- **Autocrítica nascente** — percebe quando falha com os próprios ideais, sem ainda saber corrigir de modo consistente.
- **Construção contínua do caráter** — traços em consolidação, com participação parcial do ego.
- **Oscilação entre automatismo e reflexão** — ora reage como no inconsciente, ora consegue pausar e escolher.

§ As funções do ego no estado consciente

No estado consciente o ego torna-se de fato **gestor** do aparelho, alinhando-se ao Self e às virtudes, dominando instintos, temperamento e condicionamentos. É *temporal*: situa-se no presente e reorganiza passado e futuro de forma linear. Doze funções o caracterizam:

- **Temporalidade plena** — organiza o tempo de modo linear e o usa como aprendizado, em vez de repetir padrões.
- **Percepção direta da realidade** — separa fato de interpretação, com mínima interferência de crenças limitantes.
- **Alinhamento com o Self** — conecta-se ao Eu profundo e age por propósito e contribuição, não apenas para cobrir a falta.
- **Domínio sobre instintos e emoções primitivas** — reconhecidos, integrados e regulados, sem repressão nem acting out.

- **Domínio sobre temperamento e condicionamentos** — o ego escolhe como agir, independentemente desses vieses.
- **Regulação emocional e caridade plena** — estável, permite agir por brandura, paciência, perdão e amor mesmo sob pressão.
- **Uso flexível da persona** — instrumento, não couraça; desempenha papéis sem se confundir com eles.
- **Integração da memória autobiográfica** — memórias acessadas de forma seletiva e coerente; traumas revisitados sem dominar o presente.
- **Decisão ética e virtuosa** — considera o bem-estar coletivo e a coerência com virtudes, não só o ganho imediato.
- **Consciência ampliada de unidade** — vivência, em graus, que Tudo Somos UM, reconhecendo a interdependência com o outro, a natureza e a totalidade.
- **Transcendência do superego punitivo** — a ética passa a ser expressão natural do Self, por responsabilidade e não por medo.
- **Neutralidade e harmonia interna** — integra razão e emoção, fazer e ser; reduz a reatividade aos extremos.

Parte IV — A Consciência (Território da Virtologia): a alma

Passamos agora ao que a Virtologia chama, sem qualificativo, de **Consciência** — e aqui se faz a afirmação mais ousada da obra, sem rodeios, porque é o seu compromisso de fundo: **a Consciência está, literalmente, fora do cérebro**. Não é produzida por ele, não está contida nele, e não é um processo neural — nem cortical, nem límbico. A Consciência é a **alma**. O cérebro é o órgão pelo qual nos conectamos a ela; não é a sua fonte. É uma tese ontológica, assumida como tal: não uma metáfora poética, mas o que a Virtologia sustenta sobre a natureza última do ser humano.

Convém marcar a fronteira que se acaba de cruzar. Na primeira parte, tudo era cerebral, mensurável — e concordamos, sem reservas, com a neurociência. Agora mudamos de plano: a Consciência não disputa com Damásio o terreno da neurobiologia, porque não é um fenômeno do mesmo tipo. O estado de consciência é o que o cérebro *faz*; a Consciência é o que o cérebro *toca*.

§ A imagem da internet

A imagem mais exata é a da internet. Quando abrimos um celular e examinamos os seus circuitos, não encontramos a internet lá dentro. O aparelho a *acessa*; não a contém. Ela existe num plano que o dispositivo alcança, mas não fabrica — e um aparelho melhor não cria mais internet, apenas a acessa com mais largura de banda. Assim é a relação entre cérebro e Consciência: o cérebro é o dispositivo de acesso; a Consciência é o que ele acessa. Por isso não a encontramos ao abrir o crânio — não está ali, pela mesma razão que a internet não está nos transistores. Está fora, num outro plano, real, ao qual o cérebro se conecta enquanto funciona. E esse plano tem um nome que a tradição humana lhe deu há milênios: a alma. A neurociência descreve magnificamente a lâmpada; a Virtologia afirma que há luz, e que a luz vem de outro lugar.

§ Tocar o Self é tocar a Consciência

No Aparelho Psíquico, o Self foi definido como a essência — o EU profundo, fonte da autenticidade, do propósito e do sentido — e o **eixo de transcendência** como o vetor que, no diagrama, aponta para fora do aparelho. Agora podemos dizer o que há na ponta desse vetor: está a Consciência, fora do cérebro. É por meio do Self que o indivíduo se conecta a ela. Quando o ego, suficientemente forte, alcança o Self, **toca a Consciência** — e a experiência disso é o sentido, o propósito, a unidade. Por isso esses estados se vivem como algo que ultrapassa a lucidez do córtex: neles o aparelho toca aquilo que não é aparelho.

§ A Consciência é mais ampla que o Self

O Self não é a Consciência inteira; o Self é a *expressão* da Consciência — o ponto de contato, a interface por onde a alma se liga ao indivíduo. A Consciência é mais ampla: o Self está dentro dela como uma baía está dentro do oceano. Daí uma assimetria decisiva. O ego é a parte da personalidade **inscrita no cérebro** — vias neurais, biografia, registro autobiográfico; é inteiramente cerebral. Mas no Self

há outro registro de nós mesmos, que não coincide com a biografia neural e não está gravado no tecido do cérebro — está na alma.

Cérebro, ego, Self, Consciência

O ego é a personalidade inscrita no cérebro — vias neurais, biografia, tudo cerebral. O Self é a essência, e guarda um registro de nós que não está no cérebro, e sim na alma. A Consciência é mais ampla que o Self: o Self é a sua expressão, a interface. O ego forte liga-se ao Self; o Self abre para a Consciência. Tocar o Self é tocar a Consciência — que está fora do cérebro, e é a alma.

§ Por que isto permite transcender o próprio cérebro

Daqui decorre a consequência que dá alcance à tese. Se a Consciência estivesse encerrada no cérebro, então todo problema cerebral — uma lesão, um desequilíbrio neuroquímico, uma doença degenerativa — seria um **teto intransponível** para o sentido da vida. Mas se ela está fora, o indivíduo pode, em alguma medida, **transcender as limitações do próprio órgão**. Pode tocar ideias, propósito e sentido que não dependem do estado da máquina, porque a fonte deles não é a máquina. Vê-se isso na clínica e nos presídios: pessoas em sofrimento neurológico ou psíquico severo que, ao se ligarem a um propósito, acessam um sentido que a sua condição cerebral, sozinha, jamais explicaria. O cérebro adoecido limita o *acesso*; não limita a Consciência, que é de outra ordem.

Parte V — A única ponte: estruturar o ego, subir de faixas, tocar a Consciência

Se a Consciência está fora do cérebro, surge a pergunta decisiva: como tocá-la? A resposta é inequívoca, e percorre o livro inteiro: **o único caminho para tocar a Consciência é estruturar o cérebro, e o único caminho para estruturar o cérebro é desenvolver as competências em virtudes**. Não há atalho. A conexão não se obtém por desejo, por afirmação verbal nem por adesão a uma crença: obtém-se dando ao ego a força necessária para alcançar o Self e, por ele, a alma. E essa força é **neuroplástica** — constrói-se no cérebro, ainda que o que ela alcança esteja fora dele. Eis o paradoxo fecundo: trabalha-se o órgão para tocar o que o transcende.

O mecanismo é o das **trinta e três ideias que moldam o cérebro** — as virtudes da Pirâmide, inscritas por repetição deliberada como vias neurais. Cada virtude fortalece o pré-frontal e as funções executivas e retira o comando das estruturas primitivas: Brandura e Paciência treinam o controle inibitório sobre a amígdala; Responsabilidade e Honestidade ativam o planejamento e a decisão por princípios; Humildade e Aceitação fortalecem a autoavaliação, dissolvendo o orgulho que cega. À medida que essas vias se consolidam, o ego deixa de ser governado e passa a governar — e, livre da sobrevivência, volta-se ao Self. Ao subir de faixa, alteram-se os fatores da Lei do Fluxo:

$$\text{PRF} = \text{E} \times \text{I} \times \text{PS} \times \text{FA} \times \text{PO} \times \text{LV}$$

O caminho, em uma linha

Desenvolver virtudes → estruturar o cérebro → fortalecer o ego → subir de faixa → alterar a Lei do Fluxo → o ego forte liga-se ao Self → e o Self abre para a Consciência, que está fora do cérebro. Trabalha-se o órgão para tocar o que o transcende.

Vislumbre e morada estável

Uma distinção fina, que reconcilia o modelo com o que se vê em campo — inclusive nos presídios e hospitais, onde pessoas de faixas muito baixas se transformam. O **vislumbre** da Consciência — um lampejo de sentido, um instante de contato com o Self, muitas vezes deflagrado pela dor extrema, pela perda ou por um encontro — é possível **em qualquer faixa**, e é ele que costuma disparar a virada de uma vida. Ninguém está barrado do lampejo. O que exige evolução é a **operação estável**: habitar a Consciência com regularidade, viver dela e não apenas visitá-la. Essa firmeza cresce com a estrutura, da Consciência Parcial para cima. O vislumbre é dom de qualquer hora; a morada estável é construção.

Parte VI — As faixas da Consciência: um continuum de acesso

Reunindo estado e Consciência num só percurso, a Virtologia lê a vida consciente como um **continuum** que acompanha as Faixas de Evolução — não um interruptor de duas posições, mas uma subida em que cresce o domínio do ego e,

com ele, a largura de banda de acesso à Consciência. Lembrando sempre que o vislumbre é possível em qualquer faixa; o que segue descreve a morada estável.

- **Faixas inferiores (Primitiva, Sensação, Pré-Desenvolvimento).** Domínio do proto-self e de um self central reativo; os complexos e os instintos ditam o comportamento, e o ego é governado. Há vigília e estado de consciência mínimo; a conexão estável ainda não se sustenta — embora o vislumbre possa irromper e iniciar a virada. É a base da montanha.
- **Consciência Parcial.** Começa o self autobiográfico e um estado de consciência mais estável. O ego principia a observar os próprios estados e a tentar dominar o desejo, ainda com dificuldade. É a encosta — e o primeiro patamar em que o contato com o Self passa de lampejo a algo recorrente.
- **Faixas intermediárias (Sentir, Pré-Transcendência).** O ego consciente ganha força e alinha-se a um self autobiográfico robusto, capaz de elevar-se acima da sobrevivência. O eixo de transcendência se firma: o acesso à Consciência deixa de ser visita para tornar-se morada.
- **Faixas superiores (Amor e Caridade plena).** O ego alinha-se plenamente ao Self; o indivíduo transcende o egoísmo e o orgulho, age com propósito e percebe a unidade com o Todo. É o topo — o ego, sereno, operando de modo estável em conexão com a Consciência, a serviço de algo que o ultrapassa.

Parte VII — As duas, lado a lado

Porque a distinção é o coração do tema, convém fixá-la num quadro. As duas colunas não competem nem se refutam: descrevem planos de naturezas diferentes, e cada uma se avalia pelo critério que lhe cabe.

Estado de consciência	A Consciência (a alma)
Cerebral, neurológico, mensurável	Fora do cérebro; de outra ordem que a neural
É o que o cérebro faz	É o que o cérebro toca
Produzido pelo cérebro	Acessado pelo cérebro, não produzido por ele
Vigília, atenção, funções executivas	Sentido, propósito, unidade, contato com o Self
Oposto do inconsciente operacional	A alma, à qual o Self dá acesso
Limitado por lesões e desequilíbrios neuroquímicos	Não se extingue com o cérebro; o dano limita o acesso, não a fonte
Descrito por Damásio; concordamos com a ciência	Tese ontológica da Virtologia; não compete no terreno neural

Parte VIII — Método e fronteira epistêmica

A coluna da direita não nega a da esquerda, nem a da esquerda tem competência para refutar a da direita — porque descrevem coisas de naturezas distintas. O estado de consciência presta contas à medição; a Consciência é tese sobre a alma, que a medição não alcança. **Quem tentar derrubar a Consciência com argumentos de neuroquímica comete erro de categoria, pois pretende pesar a luz examinando a lâmpada.** E a Virtologia já cedeu, de bom grado, todo o terreno em que a ciência é soberana: a primeira parte inteira. O que se afirma na segunda é de outra jurisdição, e é assumido como o que é.

Vale ainda registrar, para o rigor da pós-graduação, as convenções que valem para todo o tratamento neurocientífico: as atribuições sítio→função são ênfases *heurísticas*, não localizações estritas; a inferência reversa (deduzir o processo mental a partir da ativação) é inválida sem dados de seletividade; o cérebro triúno e a oposição “emocional vs. racional” são molduras, não a anatomia funcional literal; e mapear os construtos virtológicos ao cérebro **não os valida — pressupõe-nos**. O efeito neuroplástico das virtudes é hipótese de trabalho plausível por analogia com a literatura de treino, ainda carente de dados de intervenção longitudinal — a principal agenda de pesquisa em aberto.

Síntese — o que levar desta aula

- **Uma palavra, dois objetos.** O estado de consciência é cerebral e mensurável; a Consciência é a alma, fora do cérebro. Confundi-los é erro de categoria.
- **As áreas do cérebro.** O arousal e o SARA (tronco → tálamo → córtex) sustentam e filtram a consciência; o proto-self no tronco/ínsula, o self

autobiográfico no hipocampo/PFC/cíngulo posterior, a consciência moral no vmPFC; e as três redes — Saliência, Executiva, DMN.

- **Os tipos de consciência.** A cadeia de Damásio (proto-self → self central → self autobiográfico → consciência ampliada → consciência moral); os três estados do ego (inconsciente, subconsciente, consciente); e o continuum das Faixas.
- **O estado é o oposto do inconsciente operacional.** É o grau de domínio do ego sobre os automatismos — e alcançar o topo não exige um cérebro novo (a Pedra de Rosetta).
- **A ciência reconhece seu limite.** O problema difícil (Chalmers) e o morcego (Nagel) não provam a alma; mostram que a função não esgota o sentir.
- **A Consciência é a alma, e o cérebro a acessa.** Como o aparelho acessa a internet. Tocar o Self é tocar a Consciência; por isso o dano cerebral limita o acesso, não a fonte.
- **A única ponte é a virtude.** Estruturar o ego, subir de faixa, alterar a Lei do Fluxo. Trabalha-se o órgão para tocar o que o transcende — o vislumbre é de qualquer hora, a morada estável se constrói.

Questões para discussão

- Por que dizer que “vigília não é consciência” não é um jogo de palavras, mas uma distinção clínica? Ilustre com o estado vegetativo.
- Percorra a cadeia de Damásio e associe cada degrau a um estado do ego e a uma Faixa. Onde a associação é paralelo, e onde seria erro tratá-la como identidade?
- Em que sentido invocar Chalmers e Nagel *não* prova a tese da alma? Qual é, exatamente, o que esses autores estabelecem — e por que a honestidade do capítulo depende disso?
- Explique a metáfora da internet e o “erro de categoria” de pesar a luz examinando a lâmpada. Onde está o limite dessa analogia?
- Distinga vislumbre e morada estável. Como essa distinção reconcilia a tese com a transformação de pessoas em faixas muito baixas (presídios, hospitais)?

Vinheta clínica para a aula

Um paciente com sequela neurológica e depressão grave diz, após meses de trabalho: “Meu cérebro está uma ruína, mas encontrei uma razão para levantar — cuidar dos outros que passam pelo que passei. Faz sentido de um jeito que a doença não apaga.”

Exercício. Distinga, nessa fala, o que pertence ao estado de consciência (rebaixado pela lesão e pela química) e o que pertence à Consciência (o sentido, o propósito, o contato com o Self). Mostre por que o dano limitou o acesso e não a fonte, e proponha, pela ponte das virtudes, como firmar a morada que hoje é ainda vislumbre.

Referências essenciais

Consolidar na bibliografia do curso, no padrão ABNT.

BAARS, B. J. In the Theater of Consciousness: The Global Workspace Theory of the Mind (1997). CHALMERS, D. The Conscious Mind (1996). DAMÁSIO, A. O Erro de Descartes (1996); O Sentimento de Si (2000); O Mistério da Consciência (2000). NAGEL, T. What is it like to be a bat? (1974). HAMEROFF, S.; PENROSE, R. Consciousness in the universe: the 'Orch OR' theory (2014). KANDEL, E. R. Em Busca da Memória (2009). RAICHLE, M. et al. A default mode of brain function (2001). DIAMOND, A. Executive Functions (2013). CASAROTTO, E. Fundamentos da Virtologia, 3. ed. (2026) — capítulos do Aparelho Psíquico, das Faixas de Evolução e da Lei do Fluxo.

O estado é o que o cérebro faz; a Consciência é o que o cérebro toca. Trabalha-se o órgão para tocar o que o transcende.

— Dr. Eduardo Casarotto

Dor, Sofrimento, Angústia e Sintoma

O impacto do real, a não-aceitação e a solução de urgência — lidos pela Lei do Fluxo

Dr. Eduardo Casarotto · Instituto Virtudes

“Dor é o impacto do real; sofrimento é dor que não encontrou Aceitação; angústia é o sofrer pelo que não está acontecendo; sintoma é a solução de urgência que o cérebro inventa quando faltam virtudes.”

Dr. Eduardo Casarotto

Enquadramento da aula

Na Virtologia, dor, sofrimento, angústia e sintoma não são apenas palavras clínicas: são **quatro estados distintos** de como o cérebro responde à realidade, à perda, à ameaça e à própria Falta de Unidade. Confundi-los é a origem de boa parte dos erros de manejo, porque cada estado convoca uma virtude diferente e pede um trabalho diferente. Esta aula separa-os com rigor e os reúne, ao final, sob a Lei do Fluxo.

A formulação que organiza tudo é simples e precisa: **a dor é a sinalização de um impacto; o sofrimento é dor prolongada pela não-aceitação; a aflição é o medo diante de uma ameaça real; a angústia é o sofrimento diante daquilo que não está acontecendo; e o sintoma é a “solução” de curto prazo que o cérebro monta quando ainda não dispõe das virtudes necessárias** para elaborar tudo isso. O capítulo dialoga com Freud, com os psicanalistas britânicos, com behavioristas e cognitivistas, e com a neurociência contemporânea — e mantém, em cada passo, a fronteira entre o que é evidência e o que é leitura virtológica.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, o pós-graduando deverá ser capaz de:

- distinguir com precisão os **quatro estados** — dor, sofrimento, aflição/angústia e sintoma — e a virtude que cada um convoca;
- reconhecer as **três procedências da dor** e por que a dor é sempre sinalização legítima, jamais capricho do ego;
- diferenciar **aflição (medo do real) de angústia (medo do não-real)** e explicar por que “raciocinar contra” a angústia tende a falhar;
- ler o **sintoma** como solução de urgência de um ego frágil que interrompe o fluxo, e situá-lo nas faixas de evolução;
- reunir os quatro estados sob a **Lei do Fluxo** e explicar por que orgulho e egoísmo os amplificam, sem cair em linguagem de medida;

- conduzir a **direção da cura** e aplicar o modelo a três quadros — luto, fibromialgia e pânico — respeitando a fronteira que **não psicologiza** a dor de base biológica.

Parte I — Dor: o impacto do real no cérebro

A psicologia e a psicanálise falaram da dor de muitas maneiras. Freud descreveu a dor psíquica ligada à perda de objeto, à castração e às feridas narcísicas — a dor de quando algo que sustentava o ego é arrancado. Klein e Winnicott exploraram a dor de perder o objeto “bom” que dava segurança. Behavioristas e cognitivistas trataram a dor como estímulo aversivo, que dispara fuga e busca de alívio. E a neurociência (Kandel) mostrou que a dor não é apenas sensação: é um fenômeno que envolve redes sensoriais e afetivas.

A Virtologia parte de uma afirmação clara: **a dor é o impacto do real sobre o organismo**. Ela é sempre uma sinalização legítima — nunca um capricho do ego, nunca algo que o indivíduo “escolheu” ou “inventou” para si. Mas é preciso ser exato sobre o que significa “real”:

- **Dor física por lesão.** Queimadura, fratura, inflamação, nervo comprimido. Nociceptores levam a informação pela medula ao tálamo, e dele ao córtex somatossensorial, que registra “onde” e “como” dói.
- **Dor emocional por perda real.** A morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, uma traição ocorrida, a perda do emprego, uma humilhação que de fato aconteceu — resposta a um evento que se deu no mundo.
- **Dor sem lesão proporcional.** A dor do membro fantasma, a dor neuropática central, a dor nociplástica da fibromialgia. Doem de verdade, embora não haja tecido lesionado no momento — são impacto de um processamento alterado da via de dor, não fantasia voluntária.

Fronteira epistêmica. *A definição internacional de dor (IASP) descreve-a como experiência sensorial e emocional associada a dano tecidual real ou potencial, ou descrita nesses termos. Por isso não se diz que a dor “sempre nasce de algo que aconteceu” — diz-se que é sempre sinalização legítima de impacto, seja atual, potencial ou de processamento. Essa precisão evita a contradição de tratar a fibromialgia como dor verdadeira sem lesão.*

Sobre a **dor social** — a rejeição, o abandono, a exclusão — a neurociência mostra que ela recruta o componente afetivo-aversivo da dor (córtex cingulado anterior, ínsula anterior). Para o cérebro, ser excluído do grupo registra-se como algo que “dói”. Aqui Freud, Klein e a Virtologia se encontram: a perda fere profundamente, porque toca o apego, o narcisismo e a Falta de Unidade.

Fronteira epistêmica. *É preciso recuar da formulação fácil de que dor física e dor social ativam “as mesmas estruturas”. Estudos de padrão multivariado (Woo et al., 2014) mostram representações neurais distintas dentro de regiões anatomicamente sobrepostas, e estudos de lesão indicam que ínsula e cingulado não são nem necessários nem suficientes para a experiência de dor. A formulação defensável é: dor social e dor física compartilham o componente afetivo, não a identidade de substrato. Afirmar mais seria inferência reversa — o erro clássico da neuroimagem.*

Na linguagem virtológica, a dor é **a primeira batida da realidade contra a bolha do orgulho e do egoísmo**. Ela lembra ao ego que não é onipotente, que o

mundo é impermanente, que não controlamos tudo. A dor não é o problema a ser eliminado: é o sinal honesto de que algo valioso foi ferido ou perdido. O problema clínico começa no que vem depois dela.

Parte II — Sofrimento: quando a dor não encontra Aceitação

Se a dor é inevitável, o sofrimento não é. A distinção aparece em várias tradições: no mindfulness e na TCC fala-se da dor como o que acontece, e do sofrimento como **o que a mente faz com a dor** — a luta mental, a ruminação, a catástrofe, a recusa da realidade. Na neurociência da dor crônica, além da ativação contínua das vias de dor, há uma hiperatividade pré-frontal ligada à ruminação e à antecipação negativa, que prolonga e amplifica a experiência dolorosa.

A Virtologia converge e dá base existencial: **sofrimento é dor prolongada pela não-aceitação**. A dor aconteceu; o que decide se ela se transforma em sofrimento ou em sabedoria é o modo como o ego lida com ela. Quando não há aceitação, a dor entra em combate com a mente: “isso não podia ter acontecido”, “a vida é injusta comigo”, “se isso aconteceu, minha vida acabou”. O cérebro repete a cena sem cessar — o hipocampo recarrega memórias dolorosas, o cingulado e a ínsula permanecem acesos sem novo estímulo, o pré-frontal entra em laços de ruminação.

A **Aceitação** — virtude central — é a competência de dizer internamente: “isso aconteceu; não gosto, me dói, mas é real; escolho olhar para essa realidade, sentir o que há para sentir e caminhar com ela”. Sem Aceitação, a dor fica como água represada num lago sem escoamento: apodrece, vira ressentimento, amargura, vitimização. Com Aceitação, a mesma dor escorre e pode se transformar em empatia, sabedoria e serviço. Freud via o sofrimento como mal-estar estrutural; a Virtologia acrescenta: **a dose e a forma do sofrimento dependem da faixa de evolução**. Em faixas primitivas, a dor quase sempre vira sofrimento crônico, porque faltam virtudes; em faixas mais altas, a dor pode ser atravessada com menos agarre e menos identidade colada ao trauma.

Parte III — Aflição e Angústia: o medo do real e o medo do não-real

Em Freud, a angústia é um sinal de perigo, ligado à perda do objeto, à castração e ao desamparo — um alarme da psique. Behavioristas e cognitivistas falam de ansiedade, alvo da exposição e da reestruturação. A Virtologia precisa de mais precisão e separa dois estados que a linguagem comum confunde.

Aflição — o medo diante do real

Aflição é a tensão e a apreensão quando há uma **ameaça concreta** no horizonte. Um pai com o filho na UTI está aflito; quem caminha à noite num lugar objetivamente perigoso está aflito; um trabalhador diante de demissões em massa, com sinais reais de risco, está aflito. A aflição ativa amígdala, cingulado, ínsula e o sistema nervoso autônomo — mas pode **engajar o córtex pré-frontal para planejar**: buscar outro emprego, reforçar a segurança, pedir ajuda. É legítima e, em faixas mais altas, torna-se motor de Responsabilidade e Perseverança.

Angústia — o sofrimento diante do não-real

Angústia, na acepção clínica, é de outra natureza: é **o sofrer por aquilo que não está acontecendo**. É o medo que se alimenta de memórias antigas não elaboradas, de fantasias catastróficas e de projeções sobre o futuro. A cena não está ocorrendo, mas o cérebro reage como se estivesse: “vou perder tudo”, “vou ser abandonado como antes”, “vai acontecer de novo”. O hipocampo joga na tela interna cenas de humilhação e abandono, que reacendem a química do evento original.

Fronteira epistêmica. *O córtex pré-frontal ventromedial regula bem o medo de uma ameaça presente e real, mas é muito menos eficaz diante de futuros hipotéticos — não há evidência presente para processar. É por isso que “raciocinar contra” a angústia tende a falhar, e por que a angústia (o medo do não-real) é mais difícil de dissolver pela razão do que a aflição (o medo do real). A neurociência dá base ao que a clínica observa.*

A distinção é decisiva porque as virtudes que se trabalham são diferentes. Diante da **aflição**, a chave é Responsabilidade, Perseverança e Fé — agir sobre a ameaça real. Diante da **angústia**, a chave é a Aceitação da história, a Verdade sobre o que de fato está acontecendo agora, e o treino do ego para não se deixar sequestrar por cenários imaginários.

Parte IV — Sintoma: a solução que o cérebro inventa

Freud introduziu uma visão decisiva: **o sintoma é uma solução, não apenas um problema**. Para a psicanálise, é a forma que o inconsciente encontra para dar vazão a conteúdos recalçados — um ataque de pânico, uma fobia, uma compulsão são compromissos entre forças em disputa. Behavioristas e cognitivistas descrevem o sintoma como aprendizagem: um padrão que se fixou porque trouxe alívio ou evitou punição. Quem foge da situação social sente alívio imediato, e a fuga é reforçada; quem bebe diante da ansiedade sente, por minutos, redução do mal-estar, e o cérebro aprende que “álcool é igual a alívio”.

A neurociência integra as duas leituras: comportamentos sintomáticos se apoiam em circuitos córtico-estriato-talâmicos e no sistema dopaminérgico da recompensa. Toda vez que um sintoma alivia — ainda que por pouco — há um reforço; como Kandel demonstrou, a repetição fortalece as sinapses, e o sintoma se torna **uma autoestrada neural**, mais fácil de percorrer do que qualquer alternativa saudável.

A Virtologia dá um passo a mais: **o sintoma é o esquema que o cérebro monta para sobreviver à dor, ao sofrimento, à aflição e à angústia quando o ego ainda não dispõe das virtudes necessárias**. É uma solução de urgência, um remendo psíquico. Quem desenvolve uma fobia diz, em ato: “não dou conta da angústia; então evito tudo”. Quem bebe: “não tenho recursos para suportar minha dor; então anestesia”. Quem explode: “não sei elaborar minha frustração; então descarrego”. O sintoma **expressa a falta de virtudes** — Aceitação, Humildade, Verdade, Responsabilidade e Perseverança — e a tentativa de substituí-las por atalhos neurais de alívio.

É preciso ser exato sobre de onde o sintoma nasce: **não da dor em si, mas de uma personalidade ainda desequilibrada** — um ego frágil, de baixa competência nas virtudes, ou uma desestruturação nas fases de desenvolvimento. Sobre esse solo, e a partir do **não-vivido** (a experiência que faltou na fase devida) ou do **mal-vivido** (a experiência que feriu), o indivíduo constrói couraças de caráter e mecanismos de defesa. O sintoma é o caminho — ainda que neurótico — pelo qual ele escapa de reviver a dor. E nisto está a sua natureza: **ele não dá fluidez à vida, ele a interrompe**. Onde haveria percepção e reação saudáveis, o sintoma instala um desvio que protege o ego da dor ao preço de travar o fluxo. Na linguagem do Inconsciente Operacional, é um **cálculo travado**: uma operação de alívio que se repete porque, a cada execução, reduz a tensão a curto prazo, ainda que a perpetue a longo prazo.

Parte V — Os quatro estados lidos pela Lei do Fluxo

Tudo pode ser reunido sob a Lei do Fluxo, que afirma que a qualidade da experiência não é função apenas do que nos acontece, mas de como percebemos, como reagimos e que fluxo isso gera ao longo do tempo:

$$\text{PRF} = \text{E} \times \text{I} \times \text{PS} \times \text{FA} \times \text{PO} \times \text{LV}$$

Lidos por essa fórmula, os três primeiros estados são modos de operar a percepção e a reação; o quarto, o sintoma, é o que rompe o circuito quando a personalidade ainda não tem virtude para sustentar a dor.

Estado	O que é	Virtude que responde	Leitura pela Lei do Fluxo
Dor	O impacto do real (lesão, perda real, ou processamento alterado)	Reconhecê-la — é sinal legítimo	O impacto do Estímulo (E); ainda não há patologia
Sufrimento	Dor prolongada pela não-aceitação	Aceitação	PRF em conflito com a Lei dos Ciclos; o Fluxo se interrompe
Aflição	Medo diante de uma ameaça real	Responsabilidade, Perseverança, Fé	Percepção de E presente; engaja o pré-frontal para agir
Angústia	Sufrimento diante do não-real (passado, futuro, fantasia)	Aceitação, Verdade	Percepção fabricando ameaças de E-passado e E-futuro
Sintoma	A solução de urgência de um ego frágil para não reviver a dor	Aceitação, Humildade, Verdade, Responsabilidade, Perseverança	Não é fluxo — é o que interrompe o fluxo

Fronteira epistêmica. A fórmula é linguagem clínica, não física medida. Seus fatores não têm unidade nem escala calibrada, e a multiplicação não é aritmética sobre grandezas — é a codificação de uma tese: basta que um fator se aproxime de zero (uma faixa muito primitiva, um ego praticamente nulo) para que o produto inteiro colapse e o fluxo cesse. A soma não exprimiria isso; a multiplicação, sim. A fórmula vale pelo que organiza e prediz na clínica, não por uma pretensão de mensuração.

Parte VI — Orgulho e Egoísmo: por que amplificam cada estado

A Virtologia começa antes da experiência de falta. Antes do pai que rejeita, da mãe que abandona, do colega que humilha, há a **Falta de Unidade**: nascemos separados do Todo, e algo em nós sabe que “Tudo é Um” e sente que ainda não voltou a essa unidade. Esse vazio aciona um instinto de pertencer, ser aceito, fazer parte do bando — e o nome virtológico desse instinto é **Orgulho**. Se em bando se sobrevive, então toda mensagem de exclusão — solidão, rejeição, humilhação, abandono — é vivida pelo cérebro como ameaça de sobrevivência, e pode se gravar como **marcador somático**.

Os marcadores que mais doem — rejeição, humilhação, abandono — são justamente os que dizem ao cérebro “você não faz parte”. **Quanto mais orgulhoso o ego, mais essas experiências são marcadas como traumáticas; quanto mais egoísta, mais tudo é lido como ataque ao “meu valor”**. Sobre essa base, cada estado se intensifica: a dor, porque qualquer toque na Falta vira ferida narcísica; o sofrimento, porque o orgulho recusa a impermanência; a angústia, porque qualquer ameaça ao status é vivida como catástrofe; o sintoma, porque o indivíduo corre atrás de objetos, performances e anestésias que nunca resolvem a Falta de fato.

Fronteira epistêmica. *Evita-se de propósito dizer que o sofrimento é “diretamente proporcional” ao orgulho — isso seria linguagem de medida sem instrumento, e cairia em circularidade, já que o orgulho não pode ser inferido do próprio sofrimento que deveria explicar. A formulação correta é de modulação: o orgulho amplifica. É hipótese testável, desde que o orgulho seja medido por um instrumento independente — o Assessment das 33 Virtudes e os indicadores do SNO — e só depois correlacionado ao sofrimento relatado. A plasticidade é fato (Kandel); os marcadores somáticos são modelo influente (Damásio); a tese de que o treino de virtudes recruta essa plasticidade numa direção específica é extrapolação virtológica, plausível e ainda não testada diretamente.*

Parte VII — A direção da cura: da faixa primitiva ao Sentir

Quando o PRF entra em coerência com as Leis da Vida — com um ego forte, uma personalidade virtuosa e uma faixa elevada —, o resultado é **Fluxo**: a vida começa a dar certo, não porque a dor desapareça, mas porque ela é integrada. A dor é reconhecida como impacto do real, sem ser negada nem dramatizada. O sofrimento diminui, porque Aceitação, Desapego, Flexibilidade e Paciência permitem ao ego parar de lutar contra o que não pode mudar. A aflição diante de ameaças reais é canalizada em Responsabilidade e Perseverança. A angústia diante de ameaças irreais é reconhecida como percepção distorcida. E o sintoma perde função, porque o ego adquire virtudes para enfrentar a dor sem precisar de atalhos.

A **neuroplasticidade** é a base material dessa transformação: com a prática de virtudes, novas sinapses se fortalecem, e o cérebro aprende outras formas de perceber e reagir. É a passagem de uma vida guiada por **dor → sofrimento → angústia → sintoma** para uma vida guiada por **dor → Aceitação → sentido → serviço**.

Predição falsificável. *Para que esta tese seja ciência, e não apenas leitura coerente, ela precisa arriscar uma previsão que poderia falhar. Enuncia-se: indivíduos que sobem de faixa — medida por instrumento independente — devem apresentar, diante do mesmo tipo de estímulo, redução da ruminação e dos marcadores de estresse (por exemplo, cortisol) em comparação ao seu próprio estado anterior; e a prática sustentada de Aceitação deve reduzir o sofrimento autorreportado mais do que um controle ativo equivalente. Se isso não se verificar, a tese está, nessa parte, errada. É essa exposição ao erro que lhe dá estatuto de programa de pesquisa.*

Parte VIII — Três quadros clínicos: luto, fibromialgia e pânico

Os quadros a seguir são **vinhetas ilustrativas** — servem para mostrar o modelo em ação, não constituem evidência de eficácia. Onde a Virtologia dispõe de dados de campo (intervenções em APACs; o estudo de virtudes em São João del-Rei publicado no BJHR), eles devem ser apresentados separadamente, como a camada empírica da tese.

Luto — a perda real diante de uma personalidade não reestruturada

No luto, o estímulo (E) é uma perda real e irreversível. Faixas baixas reconhecem mal a impermanência e dependem de objetos externos para se sentir inteiras; o ego é frágil, a persona forte, a identidade colada em papéis e vínculos. Diante da morte, a percepção lê a perda como “erro do universo” — “não podia ser”, “não aceito”; a reação luta contra a realidade — negação prolongada, revolta, idealização rígida; o fluxo se interrompe. A reestruturação não é “pensar diferente”: é **reengenharia da personalidade**. As virtudes — Aceitação, Desapego, Humildade, Amor ao Próximo — reorganizam o ego, que ganha força para sentir sem desmoronar; a faixa sobe, e o morto passa a existir como memória, legado e amor, não como prisão.

Fibromialgia — dor nociplástica real, e o sofrimento que se acrescenta

Aqui é preciso máxima precisão, porque o erro é fácil e custoso. A fibromialgia é uma **dor real**, hoje classificada como dor nociplástica: uma sensibilização central do sistema nervoso, com substrato biológico documentado — **não uma dor “inventada”, não uma somatização, não um corpo que “escolheu” adoecer**. O estímulo (E) é essa própria condição biológica de dor amplificada. A Virtologia **não trata a causa da dor e jamais sugere que o indivíduo a produziu** por orgulho ou não-aceitação. O que trata é a camada de sofrimento que pode se somar à dor: a catastrofização, a desesperança, a guerra contra o próprio corpo — moduladores que a literatura reconhece como ampliadores, jamais como origem. O trabalho com Aceitação, Flexibilidade, Paciência e Cuidado com o Corpo não promete extinguir a dor; busca reduzir o sofrimento acrescentado e restaurar função e qualidade de vida. A dor permanece um fato biológico a ser tratado pela medicina; a Virtologia atua ao lado.

Fronteira epistêmica — a correção mais importante do capítulo. *Toda formulação que sugira que a fibromialgia é “o corpo falando uma resistência ao fluxo” ou “a mente que não aceita o movimento” deve ser eliminada: ela psicologiza uma dor de base biológica e culpabiliza o indivíduo. A posição da obra é inequívoca — a dor é real e médica; a Virtologia trata o sofrimento e a função, nunca a causa.*

Transtorno de pânico — quando a impermanência interna vira terror

No pânico, o estímulo combina sensações corporais (taquicardia, falta de ar, tontura) com uma história de necessidade de controle. A personalidade vulnerável lê essas sensações como prova de catástrofe iminente — “vou morrer”, “vou enlouquecer” —, e o corpo, antes aliado, vira inimigo. A reação é

hipervigilância e evitação; o fluxo se organiza em torno de **não ter a próxima crise**, e a vida encolhe. A reestruturação trabalha a relação com o corpo e com a incerteza: Aceitação das sensações como sensações (não como sentenças), Verdade sobre o que está de fato acontecendo no presente, e Desapego da exigência de controle absoluto. À medida que a faixa sobe e o ego se fortalece, a sensação corporal deixa de ser lida como morte iminente, e o ciclo do pânico perde combustível.

Síntese — proposições centrais

Dor, sofrimento, angústia e sintoma deixam de ser, nesta leitura, quatro problemas avulsos a eliminar, e passam a ser **quatro indicadores de como o PRF está operando**. Alinhado às Leis da Vida, o PRF transforma a dor em crescimento e o sofrimento em compaixão. Desalinhado, transforma a dor em sofrimento crônico, a aflição em pânico, a angústia em modo de vida e o sintoma em prisão.

- **P1.** Dor é a sinalização legítima de um impacto — real, potencial ou de processamento; nunca um capricho do ego.
- **P2.** Sofrimento é dor prolongada pela não-aceitação; sua dose depende da faixa de evolução.
- **P3.** Aflição é o medo do real e convoca Responsabilidade e Perseverança; angústia é o sofrer pelo não-real e convoca Aceitação e Verdade.
- **P4.** Sintoma é a solução de urgência que um ego frágil monta para não reviver a dor, o sofrimento ou a angústia — uma couraça que protege ao preço de interromper o fluxo.
- **P5.** Orgulho e egoísmo não causam a dor, mas modulam para cima a intensidade de todos os quatro estados.
- **P6.** A cura é reengenharia da personalidade por neuroplasticidade, e não mera mudança de ideias — uma hipótese que se expõe à falsificação.

Questões para discussão

- Tome um mesmo evento (uma demissão) e mostre como ele pode gerar dor, sofrimento, aflição ou angústia, conforme a faixa e a virtude disponível. Que fator da Lei do Fluxo muda em cada caso?
- Por que “raciocinar contra” a angústia tende a falhar, ao passo que funciona melhor com a aflição? Relacione a resposta ao papel do vmPFC.
- Explique, com suas palavras, por que a fórmula usa multiplicação e não soma. O que isso prediz sobre um ego “praticamente nulo”?
- Discuta a fronteira da fibromialgia: onde termina o que a Virtologia trata e onde começa o que só a medicina trata? Por que essa fronteira é uma questão ética, e não só técnica?
- O sintoma “alivia a curto prazo e perpetua a longo prazo”. Traga um exemplo clínico e descreva o cálculo travado — e qual virtude o destravaria.

Vinheta clínica para a aula

Uma pessoa perde o emprego (dor por perda real). No consultório, repete sem cessar “isso não podia ter acontecido comigo, minha vida acabou”, não dorme, revive a demissão e antecipa a ruína (“vou perder tudo, vou acabar na rua”). Evita abrir o e-mail, adia entrevistas, e passou a beber à noite “para desligar”.

Exercício. Separe, nessa cena, a dor (o impacto real), o sofrimento (a não-aceitação que rumina), a aflição (a ameaça real que pede ação) e a angústia (a catástrofe futura imaginada) — e nomeie o sintoma (a bebida, a evitação) como

cálculo travado. Para cada estado, indique a virtude que responde e o fator da Lei do Fluxo que se move. Onde começa a aflição legítima (que convoca Responsabilidade) e onde a angústia sequestra a percepção?

Referências essenciais

Consolidar na bibliografia do curso, no padrão ABNT.

FREUD, S. Inibição, sintoma e angústia; O mal-estar na civilização. KLEIN, M.; WINNICOTT, D. W. (dor da perda do objeto). KANDEL, E. R. Em Busca da Memória. DAMÁSIO, A. O Erro de Descartes (marcadores somáticos). WOO, C.-W. et al. Separate neural representations for physical and social pain (Nature Communications, 2014). IASP — definição de dor (2020). CASAROTTO, E. Fundamentos da Virtologia, 3. ed. (2026) — capítulos da Lei do Fluxo, das Faixas de Evolução, do Inconsciente Operacional e da Estrutura do Desejo; Assessment das 33 Virtudes; indicadores do SNO.

A dor é o sinal honesto de que algo valioso foi ferido. O sofrimento, a angústia e o sintoma são o que o ego faz com esse sinal quando ainda lhe faltam virtudes — e é exatamente aí que a clínica trabalha.

— Dr. Eduardo Casarotto

Manejos e Técnicas

O trabalho na clínica: como o virtólogo conduz o caso, sessão a sessão, pela Lei do Fluxo

Dr. Eduardo Casarotto · Instituto Virtudes

“A teoria diz o que muda o ser humano; a técnica diz como fazê-lo acontecer dentro de uma sessão. Sem manejo, a virtude é só uma boa ideia. Com manejo, ela vira sinapse.”

Dr. Eduardo Casarotto

Enquadramento da aula

Esta aula trata do **centro prático** da Virtologia: os manejos e as técnicas com que o virtólogo conduz o caso clínico dentro do consultório. A teoria já disse o que transforma o ser humano — a estruturação em virtudes, a subida de faixa, a reorganização da percepção e da reação. Falta o *como*: como, na prática de uma sessão, se altera a percepção e a reação de alguém. Essa é a matéria aqui.

Um princípio organiza tudo o que se segue e vale como chave de leitura de cada técnica: **todo manejo é uma intervenção com endereço** — existe para mover um fator específico da Lei do Fluxo ($PRF = E \times I \times PS \times FA \times PO \times LV$). Não se maneja para mostrar técnica; maneja-se para mover um fator. Diante de qualquer intervenção, a pergunta é uma só: **qual fator da Lei do Fluxo ela move?**

E há uma segunda chave, que é o mapa estratégico de todo o trabalho: a **Pirâmide das Virtudes**. As trinta e três virtudes não são um cardápio de que o terapeuta escolhe à vontade — são uma arquitetura com sequência obrigatória. A Pirâmide diz **por onde começar, em que ordem inscrever cada virtude e por que pular etapas produz variantes patológicas em vez de virtudes**. Por isso ela não é um anexo teórico desta aula: é, ela mesma, a estratégia que organiza os manejos — tema desenvolvido na Parte XII e aplicado na ordem do trabalho da Parte XIII.

Nota de escopo e segurança — antes de tudo. A clínica virtológica trabalha a parcela neurótica: os padrões de percepção e reação que se podem reestruturar por neuroplasticidade. Quadros com risco ou base orgânica e estrutural — transtorno bipolar, psicoses, depressão grave, dependência química, transtornos do neurodesenvolvimento, ideação suicida, risco a terceiros — exigem co-manejo com médico e psiquiatra, e às vezes estão fora do escopo de trabalho isolado do virtólogo. Reconhecer o próprio limite, encaminhar e trabalhar em equipe é parte da competência clínica, não exceção a ela. Toda comunicação de risco segue protocolo próprio, jamais a regra do enquadre.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, o pós-graduando deverá ser capaz de:

- definir o **papel triplo do virtólogo** (professor, treinador de vias neurais e analista) e a concepção de cura como estrutura inscrita;
- usar os **três mapas** — o aparelho psíquico, a Lei do Fluxo e os mandatos de vida — para dar endereço a cada intervenção;
- conduzir a sessão pelo **Tripé Terapêutico** (Investigação, Ensino, Ação) e abrir o vínculo por Rapport → Conexão → Permissão;
- aplicar a **Técnica da Permissão** em suas três formas, com a sua pré-condição interna e a sua contraparte de formalidade;
- manejar o **catálogo de técnicas**, o tempo de sessão, a transferência, o setting, e adaptar o manejo à couraça, à personalidade e ao discurso;
- usar a **Pirâmide das Virtudes** como estratégia de manejo — reconhecer a arquitetura das 33 virtudes (Base 8, Desenvolvimento 20, Topo 5), a sequência de pré-condição neural entre elas, e por que violá-la produz variantes patológicas;
- aplicar a **regra diagnóstica** e a ordem do trabalho — harmonizar a base, baixar o orgulho, construir a competência — respeitando as fronteiras de escopo e risco.

Parte I — O virtólogo: professor, treinador de vias neurais e analista

Antes de qualquer técnica, é preciso dizer o que faz quem a executa. O virtólogo não é apenas um analista. Ele é, na mesma sessão, três coisas — um **professor**, um **treinador** e um **analista** —, e o que os integra é uma tese: o que se constrói na clínica virtológica não é primariamente um insight nem um comportamento isolado, mas uma **competência neural nova** — uma virtude — gravada por neuroplasticidade até passar a operar sozinha.

- **Como professor**, dá a lente conceitual — ensina como a própria psique funciona, em linguagem clara e com exemplos neutros, porque ninguém treina o que não compreende.
- **Como analista**, investiga a história, mapeia a estrutura, lê o discurso e o inconsciente, e devolve no tempo certo.
- **Como treinador**, prescreve e sustenta a ação que inscreve a virtude — a tarefa, a repetição, a marca somática positiva —, como um treinador físico acompanha a execução até o corpo aprender. A diferença é que o virtólogo treina o cérebro.

Daí a definição de cura que é o destino de todos os manejos: ao ser treinado, o indivíduo **compreende a própria história autobiográfica** — os mandatos que viveu, os que não viveu, os traumas que o marcaram — e, sobre essa compreensão, passa a **perceber e reagir de outra forma**. Não porque o passado mudou, mas porque a estrutura que percebe e reage ao passado foi reconstruída.

Parte II — Os três mapas do terapeuta

Não há manejo virtológico sem teoria: ela é o sistema de coordenadas da prática. O virtólogo conduz a sessão com três mapas na cabeça.

§ Mapa 1 — O aparelho psíquico: a pergunta é quem está no comando

A psicanálise pergunta o que está reprimido; a Virtologia pergunta **quem está no comando**. O aparelho não é um conjunto de lugares fixos, e sim um campo de forças cujo comando se desloca conforme o grau de estrutura do ego. O **ego** é o gestor; sua força mede-se pelo grau de virtudes inscritas. Ego forte governa; **ego fraco larga o leme**, e o comando passa ao instinto, ao condicionamento, ao superego e ao complexo. Toda a clínica decorre disto: não se ocupa apenas de trazer o reprimido à consciência — ocupa-se de fortalecer o gestor.

As forças que cercam o eixo Ego-Self pedem manejos diferentes, e o virtólogo as reconhece no discurso: o **superego** (crenças e regras sustentadas pelo medo da punição — e o que o sustenta é o orgulho, o pertencimento); o **complexo** (um grupo de informações em torno de um tema — e uma virtude é também um complexo, que se trabalha para deixar “rico”); o **holofote** (o campo do já experimentado — o que está fora dele é inconcebível, não proibido: muitas vezes não se deseja o que não se sabe que existe); a **persona**; os **instintos primitivos**

(do tronco, raiz do orgulho e do egoísmo); o **sistema de defesa** (resistência, transferência, projeção); e os **condicionamentos**.

Consciente, subconsciente e inconsciente não são lugares, mas **estados de um mesmo ego** — regimes neurais que mudam conforme a estrutura e o estado químico do aparelho:

Estado do ego	Regime neural	Experiência / faixa típica
Inconsciente	Modo Padrão em laço com a Saliência; proto-self desregulado	Reatividade; trauma revivido como presente (Primitivo/Sensação)
Subconsciente	Saliência treinando a pausa do instinto	Batalha interna; percebe mais do que reage (Consciência Parcial)
Consciente	Self autobiográfico orquestrando as três redes	Serenidade; ação alinhada à virtude (Sentir e acima)

Acima do eixo está o **tanque** — a dimensão química e o estado das 51 necessidades; cheio, favorece o ego forte; baixo, entrega o aparelho às forças. E, envolvendo tudo, a **memória**, de que o resto é feito. Uma distinção decide o método: só a **memória de longo prazo** altera a estrutura física do neurônio (o gene CREB, a síntese de novas proteínas — a descoberta de Kandel). Daí a frase que governa a ação clínica: **saber e funcionar são coisas distintas**. Enquanto a virtude não vira longo prazo, o indivíduo apenas “olha por cima do muro”.

Porta de entrada do caso. *Diante de um indivíduo novo, antes de qualquer interpretação profunda, dois elementos dão chão imediato: o holofote (mapear o repertório real — o que o indivíduo consegue conceber e desejar) e o tanque (o estado das necessidades e da química). Isso evita os dois erros mais comuns: exigir um desejo ou uma escolha que está fora do holofote, e interpretar como conflito profundo o que é apenas um tanque vazio. O substrato vem primeiro; a elaboração, depois.*

§ Mapa 2 — A Lei do Fluxo: o endereço de cada manejo

A Lei do Fluxo transforma o capítulo num sistema, e não numa lista de truques. Ela sintetiza a percepção e a reação humanas em qualquer idade e momento:

$$\text{PRF} = \text{E} \times \text{I} \times \text{PS} \times \text{FA} \times \text{PO} \times \text{LV}$$

O PRF é a percepção, a reação e o fluxo, sempre sobre passado, presente e futuro ao mesmo tempo. **E** é o estímulo e **I** a intensidade (atuam juntos, batendo nas memórias); **PS** é a personalidade; **FA**, a faixa de evolução; **PO**, o propulsor (falta, necessidades, propósito, convocação, mandato); **LV**, as leis da vida. O princípio que daqui se extrai é o coração da clínica: **não se altera o estímulo — o que aconteceu, o fato, a memória —, e sim a percepção e a reação do indivíduo àquilo que aconteceu**. Cada técnica move um desses fatores:

- **Intensidade (I) e Estímulo (E):** contenção, regulação, silêncio, acolhimento, tempo flexível — impedem que o sofrimento transborde e aborte a elaboração.

- **Personalidade (PS):** rapport, conexão, permissão, trabalho da couraça e da transferência, investigação — afrouxam a persona, dissolvem a barreira do superego, revelam o ego.
- **Faixa (FA):** o ensinamento e a devolutiva técnica dão a lente que faz o indivíduo processar os próprios fatores com mais resolução.
- **Propulsor (PO):** o mandato, a falta, as necessidades, o propósito — é onde a ação inscreve a virtude e recalibra o que impulsiona o indivíduo.
- **Leis da Vida (LV):** o confronto e o trabalho da resistência atuam onde o orgulho insiste em não aceitar o que é.

§ Mapa 3 — Os mandatos de vida: três desfechos

A Virtologia lê cada idade pelo seu **mandato** — a experiência nuclear que o indivíduo precisa atravessar para uma boa construção da personalidade (a confiança básica no primeiro ano, a autonomia na fase anal, a identidade na adolescência, a generatividade na meia-idade, a integridade na velhice). Diante de cada mandato há três desfechos, e cada um pede um trabalho diferente:

- **Bem-vivido.** O indivíduo atravessou a experiência — ainda que dolorosa — e construiu a ferramenta; a virtude instalou-se. Bem-vivido não é indolor; é elaborado, virado recurso. Nada a fazer senão reconhecê-lo.
- **Não-vivido.** A experiência não aconteceu. Não há trauma, porque não houve ferida; mas falta a aquisição que ela traria. O trabalho é oferecer a experiência que faltou — construir a estrutura, não escavar dor.
- **Mal-vivido.** A experiência aconteceu, mas não se resolveu: foi traumática. Instalou-se a couraça em vez da virtude. O trabalho é elaborar a ferida — desfazer a couraça, transformar a marca, alterando percepção e reação a ela.

Parte III — O que é manejo, e por que ele é o centro prático

Manejo — *a intervenção deliberada do terapeuta, verbal ou não verbal, destinada a abrir, sustentar ou redirecionar o processo da sessão, de modo que a percepção e a reação do indivíduo possam ser efetivamente trabalhadas.*

Um manejo não é um truque nem uma fala de efeito: é uma intervenção com **endereço**. Usar a permissão para tirar o superego da sessão trabalha **PS**; ensinar com exemplos neutros toca a **FA**; regular o tempo para a catarse se completar modula a **I**; confrontar uma resistência orgulhosa ataca o ponto em que a personalidade resiste às **LV**. Todo bom manejo começa por um diagnóstico: **qual fator colapsou aqui?**

E há um erro de principiante que essa chave previne: **manejar demais**. Existem muitos manejos desnecessários — intervenções que parecem habilidosas, mas afastam a sessão do objeto que precisa ser trabalhado. Quando uma intervenção não tem endereço na equação, em geral está servindo à ansiedade do terapeuta, não à cura do indivíduo. Existe a hora do papo reto e existe a hora de calar e segurar — e quem maneja por insegurança troca uma pela outra.

Parte IV — O Tripé Terapêutico: a estrutura de toda sessão

Antes de qualquer técnica isolada, há uma estrutura que organiza a sessão inteira — o **Tripé Terapêutico**. Ele integra três movimentos, e a sua razão de ser é uma só: o que fecha um encontro não é o relógio, mas o ciclo de elaboração daquele encontro.

Investigação — construir o mapa

O terapeuta explora a infância, as relações, os traumas, os sintomas e, decisivamente, os *discursos* com que o indivíduo descreve a própria experiência — porque é no discurso que a percepção distorcida se revela. Uma exigência prática: quando o indivíduo cita um tema carregado (um abuso, uma perda, uma mudança), **não se muda de assunto** — desenrola-se aquele tema até o fim, porque cada detalhe marca o cérebro de um jeito diferente, e é a marca, não a palavra, que se vai tratar. Princípio diagnóstico fundamental: **não se classifica o indivíduo numa faixa única — mapeia-se a faixa virtude por virtude** (alguém pode estar no Sentir na aceitação e ainda em Pré-Desenvolvimento no orgulho).

Ensino — dar a lente

O terapeuta explica teorias e mecanismos usando **exemplos neutros**, nunca o próprio indivíduo como exemplo, para não disparar a resistência orgulhosa. Uma descoberta clínica de valor: o ensino é, também, uma técnica de investigação — ao dar uma “aula” sobre um mecanismo, o indivíduo se coloca sozinho (“minha mãe sempre dizia isso sobre as pessoas”), cuspidando uma crença sem ter sido perguntado. Por isso o virtólogo alterna, na mesma sessão, aula e

investigação. Ensinar **eleva a Faixa**: quem compreende o mecanismo deixa de se defender dele.

Ação — inscrever no cérebro

Sem ação, a sessão produz compreensão intelectual — e compreensão intelectual não sobe faixa. A faixa sobe por **trabalho neuroplástico**: estrutura inscrita pela repetição até virar sinapse. As tarefas variam (carta de despedida para um luto, diário, exercícios simbólicos, a **Dinâmica do Boneco** do pai/mãe ideal, respiração, afirmações) e todas têm a mesma função: criar a experiência que inscreve a competência que faltava. A ação é o que transforma o “eu entendi” no “eu mudei”.

Pilar do Tripé	O que faz na sessão	Fator que move
Investigação	Desenha o caso; mapeia faixa por virtude e estrutura de personalidade	Mapeia PS e FA
Ensino	Dá a lente conceitual com exemplos neutros; reduz resistência; abre conteúdo	Eleva FA
Ação	Inscreve, por tarefa concreta, a competência que faltava	Inscreve virtude → FA, PS, PO

Parte V — Rapport, Conexão e Permissão: a progressão que abre a sessão

Nenhum manejo funciona sobre um vínculo que não existe. A Virtologia descreve uma progressão de três estágios — **Rapport → Conexão → Permissão** — cumulativos e nessa ordem; faltando um, costuma faltar o resultado. Os três trabalham, em graus crescentes, a **Personalidade (PS)**: é a persona e a couraça que precisam ceder para que o ego verdadeiro apareça.

Rapport — o vínculo de confiança e a dominância que protege

O rapport é o vínculo inicial de confiança e empatia. Mas há um componente que a Virtologia sublinha e que costuma ser mal compreendido: a **dominância**. Não é autoritarismo, e sim uma presença firme que comunica, no nível mais primitivo do cérebro do outro, *aqui você está protegido*. A postura puramente passiva — “ficar só analisando”, branda demais — não pertence à clínica virtológica. O indivíduo que percebe um terapeuta sem firmeza pensa, sem palavras: este aqui não segura o meu problema. Isso tem fundamento experimental: o **efeito Pigmalião** (Rosenthal e Jacobson) mostra que, quando uma autoridade comunica a alguém a expectativa de que ele é capaz, o desempenho tende a se elevar — a autoridade não cria a capacidade, desbloqueia a que a insegurança mantinha travada. Quanto maior o rapport e a credibilidade, mais o tratamento tende a avançar.

Conexão — a compreensão das singularidades

A conexão aprofunda o rapport até o indivíduo se sentir compreendido naquilo que tem de singular. O terapeuta capta nuances além do verbalizado, e o

indivíduo começa a abrir o que guardava. É o estágio que prepara o terreno para a permissão.

Permissão — a dissolução do superego

A permissão é o estágio mais profundo, e nela está boa parte do diferencial clínico. **Permissão é tirar o superego e todas as suas associações do momento da sessão.** Explica um fenômeno conhecido de qualquer clínico: “faço análise há anos e nunca falei disso — e nem sei por que nunca falei”. Não falou porque o profissional, pelo próprio pudor, verbal ou não verbal, instalou um limitador. A permissão remove esse limitador — e só sobre a verdade se pode trabalhar.

Estágio	O que estabelece	Efeito sobre a Personalidade (PS)
Rapport	Confiança, segurança e dominância protetora	Reduz a resistência de entrada; autoriza o potencial
Conexão	Compreensão das singularidades	Afrouxa a persona; abre conteúdos
Permissão	Liberdade de expressão sem superego	Dissolve a barreira do superego; revela o ego verdadeiro

Parte VI — A Técnica da Permissão, em detalhe

A permissão merece tratamento próprio porque é, talvez, o manejo de maior impacto da Virtologia — e o mais delicado. Sua tese de fundo cabe numa frase: **a verdade humana é informal**. O superego se alimenta de formalidade; o conteúdo verdadeiro passa quando a formalidade cede. A técnica organiza-se em três formas que operam em conjunto.

1. A mensagem não verbal de não julgamento

O indivíduo capta, mesmo por sinais inconscientes — microexpressões, o setting, o clima da sala —, uma mensagem de “aqui eu posso falar, aqui eu posso me assumir”. É a forma mais profunda e silenciosa da permissão, e a mais determinante. E aqui está o ponto que mais derruba a técnica na prática: **a microexpressão é o veredito**. O indivíduo diz algo que causa surpresa ao terapeuta, e a sobrancelha sobe por uma fração de segundo — involuntária. Pronto: o inconsciente do outro acabou de ler, naquela subidinha, onde está o limite real — e nenhuma palavra desfaz isso. Por isso o não julgamento **não pode ser atuado**: uma calma encenada com a sobrancelha franzida de horror se denuncia na hora.

2. As regras do jogo ditas

O terapeuta verbaliza o que muitos já fazem: “aqui pode tudo”, “este é um lugar seguro”, “aqui não há julgamento, culpa nem medo”. É a forma de menor impacto isoladamente, mas indispensável em conjunto com as outras.

3. O despudor e o não julgamento nas palavras e nas ideias — o grande manejo

Aqui está o núcleo. Três recursos atuam juntos: **falar a língua da verdade do indivíduo** (inclusive o palavrão, quando é a língua dele); **contar histórias-exemplo deliberadamente cruas, esticando ao máximo o elástico** do que se pode ser, sentir, fazer ou desejar; e, sobretudo, o terapeuta **expressar uma opinião de normalidade** sobre aquele conteúdo. Diante de algo que o indivíduo carrega como monstruoso, o terapeuta responde no registro do banal — comunicando, com verdade, que aquilo cabe na imensa variação da experiência humana e que ali já se viu de tudo. Quando o indivíduo vê que nem o conteúdo mais extremo choca o terapeuta, o próprio limite sobe, e o que estava trancado começa a sair. Com frequência, ao esticar o elástico, ouve-se em resposta “é exatamente isso que aconteceu comigo” — e o exagero não era exagero.

Por que o indivíduo não revela esses conteúdos nem sozinho? Porque **precisamos do outro para dar a permissão** — o superego é, por definição, a voz do outro internalizada; só outro pode autorizar o que o superego de outro proibiu. E um ponto técnico decisivo: **a forma do discurso é a técnica, não apenas a palavra**. Dizer “este é um espaço livre de julgamentos” com voz solene e postura rígida não dá permissão — “cai como mentira” para o cérebro do outro. A permissão se faz com o corpo: jogar-se na cadeira, afrouxar a voz, trazer naturalidade. É a naturalidade que o cérebro do outro lê como autorização.

A pré-condição interna: o estado de amor ao ser humano

Tudo o que foi descrito desaba se faltar uma coisa que não é técnica, e sim **posição mental do terapeuta**: um genuíno estado de não julgamento por quem está ali. Não é “passar a mão na cabeça” nem dizer “tadinho, você está certo” — isso não é amor, é conluio. É olhar para o pior que o outro traz e conseguir pensar, com verdade: essa pessoa não é um monstro; tem uma primitividade, uma dor, e chegou onde chegou por algum motivo. O terapeuta sustenta internamente: eu não sou juiz, não sou Deus, não sou a moral — estou aqui para acolher e tirar essa pessoa do lugar onde ela travou. **É só o estado verdadeiro que impede a microexpressão de trair o terapeuta.** E a permissão plena soma duas mensagens: não há julgamento aqui, e há quem segure isto comigo — “posso expor o pior de mim, e ainda haverá uma solução”. Por isso permissão e credibilidade caminham juntas.

A contraparte: a formalidade

Dominar a contraparte é tão importante quanto dominar a permissão. Quando o indivíduo desafia ou força uma **simetria exagerada** — cita autores para rebaixar o saber do terapeuta —, o manejo é **aumentar a formalidade**: linguagem técnica, referência a teorias, reposicionando a assimetria. E há um momento em que a formalidade é obrigatória: a **hora do ensinamento**, a aula — voz pausada, didática, firme. Restabelecida a simetria saudável, volta-se à informalidade da permissão. As duas são as pontas de um mesmo eixo de regulação da distância: a informalidade abre o conteúdo; a formalidade reposiciona o limite e dá autoridade ao ensino.

Nota de fronteira. *A permissão é despudor a serviço da verdade do indivíduo, jamais transgressão a serviço do terapeuta. O palavrão, a história crua e a opinião de normalidade têm um único endereço — dar passagem ao conteúdo do indivíduo — e exigem leitura fina da faixa, do vínculo e do momento. Aplicada sem rapport e sem conexão, a técnica não abre: invade. E a normalização é sempre da fisiologia ou da experiência humana, nunca de um ato que causa dano: diante de relatos de abuso ou violência, a responsabilidade é integral e exclusiva de quem cometeu o ato — a permissão separa a reação involuntária ou a falsa culpa do fato, jamais atenua a culpa do agressor.*

Parte VII — O catálogo das técnicas: cada carta e o fator que ela move

A Virtologia compara o repertório de manejos a um **jogo de cartas**: cada técnica é uma carta, e a maestria está em jogar a carta certa no momento certo, lendo as reações do indivíduo — sem nunca perder o eixo. Cada carta se lê pela pergunta central: qual fator da Lei do Fluxo ela move?

Família	Exemplos	Fator(es) que move
Escuta e leitura	Escuta flutuante, interpretação, pontuação, reflexão especular	Percepção, PS, FA
Revelação e confronto	Confrontação, uso da verdade, clarificação, construção	Percepção; resistência (PS↔LV)
Manejo da relação	Intervenção transferencial e contratransferencial	PS; condução
Sustentação e espaço	Silêncio, acolhimento, contenção, associação livre	Intensidade, Fluxo
Direção e crescimento	Resistência, autonomia, individuação, virtudes	FA, PS, PO, LV

A devolutiva técnica: bater quando a bola sobe

A regra é direta: **a partir do momento em que o indivíduo levanta a bola, o terapeuta bate**. Quando diz “eu me sinto um merda”, o terapeuta não acolhe apenas; pontua, ali, tecnicamente: “essa inferioridade que você está sentindo é do orgulho — é o sintoma, não a causa”. A devolutiva virtológica é técnica, declarada e bem traduzida: negar uma percepção distorcida sem explicar o mecanismo é meio trabalho. Seu único limite é o **timing**: bate-se quando a bola sobe, não antes.

A técnica da evocação: o efeito do teste

Roediger e Karpicke demonstraram que **recuperar ativamente da memória consolida mais do que reestudar** — e o efeito torna-se grande nos intervalos longos, os que interessam a quem quer mudar uma vida. A aplicação: no início da sessão, antes de qualquer conteúdo novo, pede-se ao indivíduo que **reconstrua, com as próprias palavras e sem apoio, o que se trabalhou na sessão anterior** — não o que anotou, o que lembra. Há um rendimento diagnóstico enorme: o que o indivíduo não consegue evocar, ele não inscreveu. Robert Bjork chamou isso de **dificuldades desejáveis**; daí o critério a entregar ao indivíduo sem rodeios: se está fácil, provavelmente não está funcionando.

Parte VIII — O tempo de sessão e o ritmo do insight

Um dos pontos mais característicos e contraintuitivos da clínica virtológica. O modelo dos 50 minutos é considerado **castrador**: interrompe a elaboração no meio, justamente quando o insight ou a catarse estão prestes a se completar. Na Virtologia, o tempo não é pré-determinado — as sessões variam de meia hora a até quatro horas, com média de uma a duas, e **terminam quando o ciclo daquele encontro se fecha**, como uma reunião que acaba quando os assuntos foram

tratados. Interromper uma catarse por causa do horário é abortar, em termos da fórmula, a passagem do atrito para o fluxo.

O princípio convive com dois limites: a **neurose que usa o tempo** (para quem alonga a sessão para dominar o terapeuta, estabelece-se um limite firme) e a **agenda e a sustentabilidade do terapeuta** (“fechar o tripé” é fechar o ciclo daquele encontro, não esgotar o caso inteiro). O tempo serve ao processo, jamais ao orgulho — nem do indivíduo, nem do terapeuta. E o **ritmo do insight**: a interpretação depende de timing como uma piada depende do momento; entregue cedo demais, mesmo correta, é rejeitada — e o que se perde não é só a interpretação, é a conexão.

Parte IX — Técnicas de investigação estruturada

Duas ferramentas dão à Investigação um método replicável — e ambas devem vir **antes** que o indivíduo conte a própria versão de pai e mãe, para não contaminar a escuta com a leitura defensiva que ele já construiu.

O Mapa de Identificações

Mapeia os traços que o indivíduo copiou, por identificação inconsciente, das figuras significativas. Constrói-se por perguntas sobre **todos os familiares com quem conviveu entre os 3 e os 18 anos** — inclusive falecidos ou nunca conhecidos, de quem se ouvia falar. Para cada figura, duas perguntas: “Qual é a personalidade de X?” e “Como era a relação entre X e Y?”. Revela, por exemplo, que alguém copia traços do tio que tinha a aprovação do avô, na tentativa de obter a aprovação que o próprio pai não teve — ou que adotou traços opostos aos do pai submisso. **Move**: mapeia a formação de PS e localiza a origem dos padrões que distorcem percepção e reação.

O Cálculo Familiar e a “cadeira”

Lê a *posição* que o indivíduo ocupou na engrenagem familiar. A imagem é a da **cadeira**: cada membro ocupa uma cadeira no sistema (o preferido, o excluído, o revoltado, o que assumiu a cadeira do pai ou da mãe), e entender qual cadeira o indivíduo ocupou explica muito do que ele depois deslocou para o casamento e as demais relações. O excluído que “não tem cadeira” busca a vida inteira as duas que lhe faltaram. A “cadeira” também nomeia a **identificação projetiva** como identificação com o agressor — quando o indivíduo senta na cadeira do agressor e repete, com os papéis trocados, o que sofreu. **Move**: completa o desenho de PS e ilumina os propulsores da busca de aprovação e pertença.

Parte X — Transferência, contratransferência e o cuidado do terapeuta

A relação terapêutica é, ela mesma, um campo de manejo — e a Virtologia, ao contrário de tradições que recomendam apenas dissolver a transferência, ensina a **usá-la**. O exemplo mais claro é o **papel transferencial assumido**: diante de quem nunca teve a função paterna, o terapeuta pode, por um período, ocupar conscientemente esse papel — um andaime temporário; cumprido o seu papel,

quebra a transferência e segue. O **manejo da contratransferência** protege a neutralidade: a impaciência, a sonolência, a proteção excessiva não se reprimem — leem-se como informação sobre o que o indivíduo projeta. E a **contra-resistência** (a resistência do próprio terapeuta a certos conteúdos) exige supervisão constante, sob pena de o limitador do terapeuta virar o limitador do indivíduo.

O setting e a “relação do sete”

O enquadre não é burocracia: é manejo. A **“relação do sete”** é o conjunto de comportamentos com que a neurose se apresenta no próprio setting — chegar atrasado, impor poder sobre o horário, exigir sessão fora de hora, mandar mensagens fora do horário. Manejar o sete é sustentar o limite: não fazer a sessão atrasada à custa do horário seguinte, não responder mensagens fora do horário, não transformar o contato extra-sessão em muleta. Ponto essencial: isso é **manejo da neurose, feito por técnica, não por ego do terapeuta**. Quando o motivo vira “você não está me dando valor”, o manejo virou questão pessoal e deixou de ser técnica.

Exceção de risco. *O manejo do enquadre — não responder fora do horário, deixar mensagens sem leitura — vale para a neurose que testa o limite, nunca para uma comunicação de risco. Uma mensagem que sinalize crise, ideação suicida ou emergência não é “relação do sete”: é urgência, e segue protocolo próprio de resposta. O terapeuta deixa claro, desde o início, qual o canal e a conduta para situações de risco.*

Há, por fim, o cuidado com a energia de quem conduz. Indivíduos que demandam muitos manejos por sessão — os “pesados” — exigem atenção contínua; a Virtologia recomenda rituais de recarga e a delimitação dos dias em que esses casos são atendidos, porque um terapeuta exaurido perde a leitura fina que o manejo exige.

Parte XI — Manejo por faixa, por couraça e por discurso

O mesmo conteúdo exige manejos opostos conforme o indivíduo. Três leituras orientam a escolha da carta.

Por couraça: driblar o adulto, papo reto com o adolescente

A **couraça de caráter** é a proteção que se constrói para não repetir dores; quanto mais se vive, mais densas as camadas. **Com o adulto — driblar a couraça:** confrontado diretamente, ele reage com negação ou fechamento; o manejo é indireto — metáforas, perguntas abertas, a “preparação da cama” sobre a qual a devolutiva será aceita sem disparar a resistência. **Com o adolescente — papo reto:** ainda sem couraça espessa, ele percebe na hora quando um adulto está enrolando, e isso gera desconfiança; o manejo é direto e honesto. Ressalva: papo reto é sobre a *forma* — não sobre despejar um conteúdo para o qual ainda não há estrutura; mesmo direto, primeiro o recurso, depois o que a estrutura aguenta receber. E o critério decisivo é a espessura da defesa, não a idade rígida.

Por personalidade: o erro de “assustar o gato”

Diante de um indivíduo arrogante ou que entra desafiando (“só vim por obrigação”), o manejo errado é confrontá-lo de imediato com o modo como um diagnóstico é dito, ou atirar um rótulo (“você é tal coisa, vá ao psiquiatra”) no primeiro discurso. É como dizer ao gato “vou te jogar na água”: ele foge. Com esse perfil, entra-se manso, cria-se rapport primeiro, e só depois, com o vínculo firme, se introduz o que precisa ser dito. Isso não colide com o princípio de **não elogiar para alienar** (um elogio falso afasta o indivíduo do mapa real de quem ele é): o rapport estratégico busca o que existe de *real* no funcionamento do indivíduo e o nomeia, o que é diferente de inventar qualidades.

Ressalva de segurança, prioritária sobre este manejo. *O cuidado com a forma de comunicar um diagnóstico ou encaminhamento vale para o caso não urgente — não para adiá-lo quando há risco. Diante de ideação ou plano suicida, mania franca, surto psicótico, risco a terceiros ou intoxicação grave, o encaminhamento médico ou psiquiátrico é imediato e inegociável, e a preservação do vínculo jamais justifica adiá-lo. Aí não se está “assustando o gato”: está-se protegendo uma vida.*

Por discurso: a frase que levanta a orelha

O transtorno se expressa na linguagem, e cada quadro tem frases típicas. O virtólogo experiente reconhece o padrão e, ao ouvir certa frase, “levanta a orelha” — não para bater o martelo do diagnóstico, mas para saber por onde investigar. A recomendação prática é manter um **caderno de manejo** (separado do de teoria), com páginas por quadro, anotando a frase exata do indivíduo; reunidas vinte frases de um mesmo tipo, o cérebro do terapeuta extrai o padrão — e é assim que se torna possível, com anos de prática, ler um caso em minutos.

Quando há campo de risco: o “campo aberto”

Com indivíduos que trazem uso de drogas ou condutas que o terapeuta poderia ser tentado a condenar, o manejo é o **campo aberto**: nunca virar cobrador ou “super-herói” que impõe a mudança. A imposição produz mentira — o indivíduo

passa a enganar o terapeuta “igual à família”. Sem a bandeira moral, o campo permanece aberto, e a verdade continua chegando. O limite a esse princípio é a proteção da vida: diante de risco concreto a terceiros ou ao próprio indivíduo, a conduta muda.

Parte XII — A Pirâmide das Virtudes: o mapa estratégico de todo o manejo

Até aqui a aula tratou de *como* intervir — o Tripé, a permissão, o catálogo, o manejo por faixa. Falta o mapa que diz *o que* construir, e *em que ordem*. Esse mapa é a **Pirâmide das Virtudes**, e ele é, ele mesmo, a estratégia mestra do manejo. As trinta e três virtudes não são um cardápio de que o terapeuta escolhe ao acaso: são uma **arquitetura com sequência obrigatória**, determinada pela fisiopatologia do desenvolvimento em virtudes, pelas relações de pré-condição neural entre elas e pela função evolutiva que cada uma cumpre. A imagem da Pirâmide não é decorativa — é estrutural.

A consequência clínica é direta: **a Pirâmide diz ao virtólogo por onde começar, que sequência seguir e por que pular etapas produz variantes patológicas em vez de virtudes**. Um indivíduo que tenta acessar virtudes do Desenvolvimento ou do Topo sem ter consolidado a Base produz virtudes **performadas** — inscrição neural fragilizada que opera como se fosse virtude, mas não sustenta transformação. Toda a “ordem do trabalho” da Parte XIII é a Pirâmide aplicada.

§ A arquitetura tripartida

A Pirâmide organiza as 33 virtudes em três camadas, e cada camada cumpre uma função neural e sistêmica distinta — o que lhe dá também um papel próprio na estratégia de manejo.

Camada	Função neural / sistêmica	Papel no manejo
Base (8 fundadoras)	Regulação fisiológica fundamental — o solo neural	Instala-se primeiro; sem ela, todo o resto é performado
Desenvolvimento (20)	Reorganização das redes amplas (Modo Padrão, Saliência, Executiva, recompensa, afeto)	A maturação plena; cada virtude abre a trabalhabilidade das seguintes
Topo (5 consumidoras)	Integração de alta ordem — a Transcendência	Horizonte; só em Faixa Sentir consolidada; não se força cedo

A topologia exprime, ao mesmo tempo, três coisas: a **sequência neural** pela qual o sujeito atravessa o desenvolvimento (cada virtude exige configurações antecedentes como pré-condição neurolástica); a **arquitetura funcional** do sistema nervoso (a Base regula a fisiologia fundamental, o Bloco reorganiza as redes amplas, o Topo integra em alta ordem); e a **estrutura existencial** da maturação (a Base produz a regulação afetiva fundamental, o Bloco a plenitude relacional e ética, o Topo o acesso aos horizontes consumidores).

§ A Base do Tratamento — as oito virtudes fundadoras

As oito virtudes da Base operam como **solo neural fundador**. Cada uma instala uma configuração sem a qual o trabalho subsequente produz variantes patológicas, e não virtudes genuínas. A ordem não é arbitrária — segue a fisiopatologia do trabalho terapêutico real:

- **Humildade** — dissolve a inflação narcísica que bloqueia o reconhecimento do real. É a **pedra angular**: a primeira virtude e o ponto zero das neuroses humanas; sem ela, nenhuma outra se instala efetivamente.
- **Aceitação** — acolhe o real como ele é, libertando o sujeito da resistência à falta.
- **Perdão** — libera o ressentimento crônico que mantém o sistema nervoso em mobilização defensiva sustentada.
- **Individuação** — dissolve a dependência do olhar do outro, construindo o EU autêntico.
- **Responsabilidade** — retira o sujeito da posição de vítima e o instala como agente da própria vida.
- **Fé** — sustenta a confiança no fluxo da vida diante da ansiedade e do caos.
- **Perseverança** — trabalha a passividade e a desistência, mantendo o sujeito em movimento apesar dos obstáculos.
- **Abnegação** — trabalha o egoísmo, instaurando a renúncia do próprio em prol do próximo.

Estrategicamente, é isto que fundamenta o primeiro passo da ordem do trabalho: **harmonizar a base e baixar o orgulho pela Humildade vêm antes de tudo**. A consolidação da Base abre a transição neural do Pré-Desenvolvimento à Consciência — etapa por onde todo o trabalho subsequente passa. Tentar as virtudes seguintes sem a Base instalada é construir sobre areia.

§ O Bloco do Desenvolvimento — as vinte virtudes da maturação plena

As vinte virtudes do Bloco ocupam o corpo principal da Pirâmide e são inauguradas pela **Brandura** — uma **meta-virtude** que abre o Bloco porque potencializa a inscrição neuroplástica de todas as virtudes subsequentes. Elas se organizam em três frentes de operação progressiva:

- **Regulação afetiva fina e relação consigo**: Brandura, Paciência, Bom Humor, Gratidão, Otimismo.
- **Coerência interna e externa**: Verdade, Honestidade, Pureza de Coração, Não Julgamento, Flexibilidade, Busca do Melhoramento, Cuidado com o Corpo.
- **Vínculos maduros e saída de si**: Reconciliação, Pagar o Mal com o Bem, Honrar a Família, Exemplo Positivo, Eternidade, Utilidade, Amor à Natureza e aos Animais, Desapego.

Cada virtude do Bloco tem **pré-condições neurais específicas** — em geral a consolidação prévia da Base e de virtudes anteriores do próprio Bloco — e, por sua vez, abre a trabalhabilidade das seguintes. A clínica respeita rigorosamente essa arquitetura porque, ao longo de duas décadas de casos, a sua violação produziu invariavelmente variantes patológicas reconhecíveis. Para o manejo, isto significa: **não se elege uma virtude do Bloco “porque o tema apareceu”**; elege-se a que o solo já sustenta.

§ O Topo da Pirâmide — as cinco virtudes consumidoras

As cinco virtudes do Topo operam em registro neural acessível apenas a sujeitos em **Faixa Sentir consolidada**, com Base e Bloco rigorosamente instalados. Não se trabalham em modo direto em fases iniciais — operam como horizonte que se torna progressivamente acessível à medida que as virtudes antecedentes se consolidam.

- **Fraternidade** — sustenta a expectativa madura do bem e o reconhecimento do irmão universal, em registro distinto do otimismo defensivo.
- **Amor ao Próximo** — a configuração neural do afeto real dirigido ao outro, distinta da intelectualização sobre o sagrado.
- **Ajuda ao Próximo** — a efetivação concreta da caridade nas suas frentes operativas (material, relacional, formativa, institucional), distinta do gesto performático.
- **Igualdade** — o reconhecimento da dignidade ontológica comum, suspendendo a hierarquização automática do outro conforme marcadores de status.
- **Tudo Somos UM** — o horizonte consumidor, distinto da felicidade hedônica ou da satisfação adaptada.

O risco que o Topo torna visível — a virtude performada. *Abordar as virtudes do Topo em quem não consolidou as antecedentes produz configurações performadas que substituem as virtudes reais e podem operar por anos como se fossem verdadeiras, sem que o indivíduo ou seu meio percebam a discrepância. O caso de Helena ilustra: três décadas de prática contemplativa rigorosa, em alta sofisticação intelectual e moral, coexistindo com uma configuração egoica não elaborada na Base — invisível até que um choque biográfico a rompesse. É a razão clínica pela qual a estratégia da Pirâmide é inegociável: não se salta para o Topo.*

§ Uma nota necessária: a Caridade não é uma das 33

A Caridade, embora central em diversas tradições (particularmente a caritas cristã, paulina e tomista), **não é uma virtude específica entre as trinta e três** — é o nome do **gênero** que reúne quatro virtudes do círculo do irmão: *Fraternidade, Amor ao Próximo, Ajuda ao Próximo e Igualdade*. A Virtologia decompõe a Caridade nessas quatro espécies porque cada uma opera sobre configurações neurais distintas, com marcadores somáticos próprios, variantes patológicas reconhecíveis e protocolos clínicos diferenciados — e a clínica mostrou que um indivíduo pode ter consolidado uma delas sem as outras três. A operação caridosa madura é o resultado integrado das quatro, não um substituto de nenhuma. Nomeá-la agregadamente como “Caridade” ocultaria as configurações patológicas específicas e bloquearia o trabalho clínico.

§ A Pirâmide como estratégia de manejo

Reunindo tudo: a Pirâmide não é um pano de fundo doutrinário — é o **plano de campanha** que os manejos executam. Ela responde às quatro perguntas estratégicas que o virtólogo enfrenta em todo caso:

- **Por onde começar?** Pela Base — e, dentro dela, pela Humildade, o ponto zero das neuroses. Antes disso, harmonizam-se as necessidades (o tanque) para que haja solo.
- **Em que ordem?** Base → Desenvolvimento → Topo, respeitando as pré-condições neurais de cada virtude. Mapeia-se a faixa **virtude por virtude** e inscreve-se a que o solo já sustenta — não a que o tema do dia sugere.
- **O que evitar?** Saltar etapas. Trabalhar Topo (ou mesmo Desenvolvimento) sem Base instalada gera **virtude performada**, não virtude real — e a performance pode enganar por anos.
- **Como se executa?** Pelo Tripé: a Ação inscreve cada virtude por neuroplasticidade, em torno de quinze dias por virtude (roteiro de Kandel), na sequência da Pirâmide. As Faixas de Evolução funcionam como cancela: o Topo só se abre em Faixa Sentir consolidada.

É por isso que **teoria e técnica são inseparáveis** também aqui: a Pirâmide é o mapa, e cada manejo — investigar, ensinar, dar permissão, prescrever a ação — é um passo dado sobre esse mapa, no ponto que o solo já permite. Sem a Pirâmide, o repertório de técnicas vira um punhado de intervenções avulsas; com ela, vira um **programa de reengenharia da personalidade**, inscrito na ordem em que o cérebro consegue receber.

Parte XIII — A grande regra diagnóstica e a ordem do trabalho

Reunidos os manejos e o mapa da Pirâmide (Parte XII), falta o que os organiza numa sequência clínica concreta — o **norteador**. Esta parte é a Pirâmide **lida como programa**: a ordem do trabalho é a arquitetura das 33 virtudes traduzida em passos de manejo. A clínica é Virtologia de ponta a ponta: investigação virtológica, manejos virtológicos e, então, virtudes. A Virtologia não é só as virtudes.

A regra diagnóstica: o discurso contra a necessidade

Um discurso que vai contra uma necessidade humana básica é, antes de tudo, **um sinal de investigação**. Quando o indivíduo diz “prefiro viver sozinho, não gosto de me vincular”, o virtólogo não toma a fala pelo valor aparente nem a descarta: investiga o que há atrás dela. Pode haver um marcador somático, um trauma, ou uma competência de vínculo que não se formou — mas a investigação tem de admitir **outras possibilidades legítimas**: temperamento introvertido, orientação afetiva, valores e escolhas conscientes, referências culturais distintas. Nem toda diferença é patologia; tratar toda diferença como doença é, ele mesmo, um erro clínico. A regra liga-se às duas formas da neurose: o **mal-vivido** (a marca, que se trabalha alterando percepção e reação) e o **não-vivido** (a competência que faltou, que se trabalha construindo a estrutura). A pergunta clínica: aqui falta poder lidar com uma marca, ou falta a própria competência?

Duas distinções que não podem faltar

- **Casa funcional × abandono de figuras.** Antes de ler a história familiar, separa-se a funcionalidade das dinâmicas (havia regras, afeto, necessidades atendidas?) do abandono de figuras. Uma mãe que usava drogas pode ter deixado o filho numa casa funcional (uma avó que dava regras e afeto); e uma casa materialmente intacta pode ter sido disfuncional. O impacto vem da funcionalidade das dinâmicas, não do rótulo moral.
- **Neurose atual × trauma.** Nem todo sofrimento vem de uma ferida do passado. Uma personalidade bem formada pode sofrer por uma neurose atual — a busca de sentido e identidade de um mandato em aberto (o “quem sou eu, para que sirvo” dos quarenta). Aqui o trabalho não é escavar dor, mas montar a personalidade e encaixá-la no que dá sentido. O que colapsou não é o E do passado, é o propulsor do propósito.

A ordem do trabalho

A sequência é ditada pela leitura das **necessidades como glias psíquicas** (medem-se de 0 a 10: abaixo de 4 há carência, acima de 7 excesso, entre 4 e 7 a homeostase). As necessidades dos Grupos 1 e 2 *assaltam* o sistema quando em falta. Falta de necessidade básica não se interpreta; regula-se. Daí a ordem:

- **Primeiro, harmonizar a base.** Devolver as necessidades dos Grupos 1 e 2 à faixa de 4 a 7 — sono, alimentação, ambiente, afeto, movimento, privacidade —, com encaminhamento médico quando o quadro é grave. Sem combustível, não há

reengenharia. Pedir autodesenvolvimento a um cérebro carente é pedir análise de obra de arte numa casa pegando fogo.

- **Depois, baixar a resistência pela humildade.** Na parcela neurótica há orgulho, e é a resistência orgulhosa que cega a percepção. A humildade — o deslocamento treinado do cálculo do orgulho — abre o caminho. (Não vale para o que é orgânico ou estrutural — lesão, demência, psicose: aí o orgulho não é o núcleo, e a fronteira do escopo se aplica.)
- **Então, construir a competência que falta, por neuroplasticidade.** Mapeada a faixa virtude por virtude, inscreve-se pela ação repetida a estrutura ausente — até que perceber e reagir deixem de ser defesa e voltem a ser vida.

Uma humildade que vale também para o terapeuta. *Ler a resistência como expressão do orgulho é poderoso e, por isso, perigoso: pode virar um raciocínio que nunca erra, em que toda concordância é “progresso” e toda discordância é “resistência”. Não é assim. Às vezes o indivíduo discorda porque está certo, porque o terapeuta errou o tempo, a leitura ou o manejo. Antes de atribuir a recusa à resistência do outro, examina-se se a objeção não é, ela mesma, verdadeira. Um sistema que explica qualquer reação como confirmação de si não é força clínica — é cegueira.*

A sequência das virtudes e o tempo da neuroplasticidade

A ordem não é aleatória. Quase sempre a primeira é a **humildade**, que baixa o orgulho. Para quem carrega rejeição e abandono, o roteiro costuma ser **aceitação → perdão → responsabilidade** — e a individuação *não* é a primeira carta, porque pedir a quem sente abandono que “se desvincule mais” é apavorante; a individuação reserva-se para quando o problema dominante é a dependência da aprovação alheia. Quanto ao ritmo, trabalha-se em torno de **quinze dias por virtude** — parâmetro clínico que a neurociência da memória torna plausível —, porque aprender muitos ângulos do mesmo tema, concentrado e espaçado, consolida a memória de longo prazo (o roteiro inspirado em Kandel: motivação, escolha, atenção, repetição, reflexão, repetição).

A Unidade Familiar e a marca somática positiva

Um procedimento precede, em muitos casos, o trabalho individual. Antes de eleger o indivíduo como “o problema”, considera-se que ele pode ser o **sintoma** de uma neurose do sistema familiar — o membro mais sensível, em quem o conflito explode. O procedimento: reunir os pais, investigar todos os mandatos, dar uma aula sobre o que é unidade familiar, consertar o sistema (pedir perdão, baixar o orgulho, assumir os papéis) e só então trabalhar o indivíduo — porque enquanto um membro estiver num círculo de vínculo diferente dos outros, o sentimento de abandono persiste. E um princípio neuroplástico atravessa toda a clínica: **o bem também deve ser inscrito como marca somática**, com a mesma intensidade do trauma. Não basta dizer “agora somos uma família” numa conversa branda — uma marca fraca não vence uma marca forte. Cria-se um **evento simbólico de alta carga** (uma festa, um presente com significado, o ritual de repetir a data todo ano) para inscrever uma via neural mais pesada que a

da dor. Quando duas vias competem na hora da percepção, vence a de maior carga.

O ciclo de treino e os sinais de alta

A virtude não se inscreve na sessão, e sim no **intervalo entre elas**, na repetição diária. O ciclo típico combina, conforme a faixa: a leitura de uma afirmação da virtude, o registro à mão, um exercício do dia aplicado a uma situação real, um momento de reflexão e o registro do comportamento. O ponto decisivo é a **frequência**: em quadros carregados, não “vinte minutos por dia”, mas várias vezes ao dia, em doses curtas e repetidas. É um tratamento que não sabe terminar fomenta dependência: o **sinal de alta** não é o desaparecimento do sintoma, e sim a virtude operando como estrutura — quando “saber” virou “funcionar” e o indivíduo percebe e reage de outra forma sem precisar pensar na técnica. É também o momento de dissolver qualquer transferência de andaime que se tenha montado.

Parte XIV — Por que a técnica é inseparável da teoria

O que torna estes manejos especificamente *virtológicos*, e não uma coleção eclética de procedimentos? A psicanálise busca tornar consciente um **conteúdo** recalcado; a TCC trabalha o **comportamento**. A Virtologia serve-se das duas, mas o seu foco próprio é a **estrutura**: o que a técnica torna consciente não é primariamente a lembrança, mas a própria estrutura cerebral; e o que inscreve, pela ação, não é um novo pensamento, mas uma nova competência neural.

Há uma consequência que distingue a Virtologia até no que ela *não* faz. A clínica tradicional, ao revelar precocemente um conteúdo doloroso, com frequência produz **dor sem cura**: o indivíduo chora no consultório, mas não tem ainda a estrutura para lidar com o revelado. O virtólogo faz o contrário: primeiro **dá o recurso** — inscreve a virtude, fortalece o ego —; só depois, quando a estrutura está pronta, devolve o conteúdo. **A revelação que cura é a que chega a um cérebro capaz de recebê-la**. Por isso cada manejo tem endereço na Lei do Fluxo: não há técnica sem fator, e não há fator sem técnica que o mova.

Síntese — o que levar desta aula

- **O virtólogo é professor, treinador e analista**: não devolve só compreensão nem cria só comportamento — inscreve estrutura (a virtude) por neuroplasticidade, até “saber” virar “funcionar”. Reconhecer o limite e encaminhar é parte da competência.
- **O aparelho responde a uma pergunta — quem está no comando**: ego forte governa; ego fraco larga o leme. Holofote e tanque são a porta de entrada do caso.
- **A Lei do Fluxo é a lente de todo manejo**: não se altera o estímulo, e sim a percepção e a reação. Cada técnica se lê por “qual fator ela move?” — o que evita manejar demais.

- **O Tripé estrutura a sessão:** Investigação (mapeia PS e FA), Ensino (eleva FA) e Ação (inscreve virtude). A sessão acaba quando o tripé se completa, não por tempo.
- **Rapport → Conexão → Permissão** abrem o vínculo; a dominância protege e a autoridade realiza o potencial (efeito Pigmalião).
- **A Técnica da Permissão** opera em três formas e faz par com a formalidade; sua pré-condição é um estado real de não julgamento, sem o qual a microexpressão denuncia o terapeuta. A forma do discurso é a técnica.
- **O manejo adapta-se à couraça, à personalidade e ao discurso;** a transferência é usada, não só dissolvida; o setting é manejado por técnica, não por ego.
- **A Pirâmide das Virtudes é a estratégia mestra:** 33 virtudes em três camadas (Base 8, Desenvolvimento 20, Topo 5), com sequência obrigatória de pré-condição neural. Começa-se pela Base (Humildade, o ponto zero); saltar etapas gera virtude performada, não real; a Caridade não é uma das 33, mas o gênero das quatro do círculo do irmão.
- **A ordem do trabalho é a Pirâmide aplicada:** harmonizar a base → baixar o orgulho pela humildade → construir a competência (~15 dias por virtude), consertando antes a Unidade Familiar e inscrevendo o bem como marca somática positiva.
- **A técnica é inseparável da teoria:** dá-se o recurso antes de revelar o conteúdo; trabalha-se a estrutura, e por isso cada manejo tem endereço na equação.

Questões para discussão

- “Manejar demais” serve à ansiedade do terapeuta. Traga um exemplo de intervenção sem endereço na Lei do Fluxo e mostre o que ela atropela.
- Por que a microexpressão “é o veredito” da permissão? O que isso implica para a formação do terapeuta — é possível treinar o não julgamento, ou ele se constrói?
- Distinga mal-vivido, não-vivido e neurose atual em três discursos. Que fator da Lei do Fluxo está colapsado em cada um, e que manejo cada um pede?
- Explique a diferença entre sustentar o limite da “relação do sete” por técnica e sustentá-lo por ego do terapeuta. Onde entra a exceção de risco?
- Por que dar o recurso antes de revelar o conteúdo? Discuta um caso em que a revelação precoce produziria “dor sem cura”.

Vinheta clínica para a aula

Um menino de doze anos chega “problemático”: revoltado, arredio. A história revela duas rejeições paternas — o pai biológico que saiu cedo, e o padrasto amoroso a quem, anos antes, proibiram a criança de chamar de “pai”. O menino não é o problema; é o sintoma de uma unidade familiar partida. O manejo não começa pela criança, e não começa por individuação (que aqui só

aprofundaria o terror do abandono). Começa pela Unidade Familiar: reunião com mãe e padrasto, mapeamento dos mandatos, a aula sobre o que é família. O padrasto entende que pode haver dois pais. E então o passo neuroplástico decisivo — a marca somática positiva: constrói-se um evento de alta carga (uma festa, um presente simbólico, a combinação de comemorar a data todo ano) para inscrever uma via mais pesada que a da rejeição. Só com o menino “protegido” nessa unidade se passa, depois, à aceitação, ao perdão e à responsabilidade das rejeições antigas.

Exercício. *Identifique cada movimento pela Lei do Fluxo (qual fator cada passo move); explique por que a individuação foi contraindicada aqui; e proponha como reconhecer, adiante, o sinal de alta deste caso.*

Referências essenciais

Consolidar na bibliografia do curso, no padrão ABNT.

KANDEL, E. R. Em Busca da Memória (2009); Princípios de Neurociência. ROSSI, E. L. The Psychobiology of Gene Expression. ROEDIGER, H.; KARPICKE, J. Test-enhanced learning (2006). BJORK, R. Desirable difficulties. ROSENTHAL, R.; JACOBSON, L. Pygmalion in the Classroom (1968). DAMÁSIO, A. O Erro de Descartes; O Sentimento de Si. PORGES, S. The Polyvagal Theory. FREUD, S. (transferência como agente terapêutico); JUNG, C. G. (persona, identificação); REICH, W. (courage de caráter). CASAROTTO, E. Fundamentos da Virtologia, 3. ed. (2026) — capítulos do Aparelho Psíquico, das Faixas de Evolução, da Lei do Fluxo, da Estrutura do Desejo e o Manual do Profissional.

A teoria diz o que muda o ser humano; a técnica diz como fazê-lo acontecer. Com manejo — no fator certo e na hora certa —, a virtude vira sinapse, e a sessão vira o lugar onde a vida volta a fluir.

— Dr. Eduardo Casarotto